

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
ESCOLA DE ENFERMAGEM E DE SAÚDE COLETIVA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM**

**AMBIENTE DA PRÁTICA PROFISSIONAL E PREDITORES DA QUALIDADE DO  
PRODUTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM**

**NICOLE HERTZOG RODRIGUES**

**Porto Alegre - RS**

**2026**

**NICOLE HERTZOG RODRIGUES**

**AMBIENTE DA PRÁTICA PROFISSIONAL E PREDITORES DA QUALIDADE DO  
PRODUTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Enfermagem.

**Área de concentração:** Políticas e práticas em saúde e enfermagem.

**Linha de Pesquisa:** Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho.

**Orientador:** Prof. Dr. João Lucas Campos de Oliveira.

**Porto Alegre - RS**

**2026**

#### CIP - Catalogação na Publicação

Hertzog Rodrigues, Nicole  
AMBIENTE DA PRÁTICA PROFISSIONAL E PREDITORES DA  
QUALIDADE DO PRODUTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM / Nicole  
Hertzog Rodrigues. -- 2026.  
130 f.  
Orientador: João Lucas Campos de Oliveira.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio  
Grande do Sul, Escola de Enfermagem, Programa de  
Pós-Graduação em Enfermagem, Porto Alegre, BR-RS,  
2026.

1. Ambiente de Trabalho. 2. Gestão da Qualidade. 3.  
Qualidade da Assistência à Saúde. 4. Cuidados de  
Enfermagem. 5. Pesquisa em Administração de  
Enfermagem. I. Campos de Oliveira, João Lucas, orient.  
II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os  
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

**NICOLE HERTZOG RODRIGUES**

**AMBIENTE DA PRÁTICA PROFISSIONAL E PREDITORES DA QUALIDADE DO  
PRODUTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM**

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Enfermagem.

Aprovada em Porto Alegre, 11 de dezembro de 2025.

**BANCA EXAMINADORA**

Documento assinado digitalmente  
 **JOAO LUCAS CAMPOS DE OLIVEIRA**  
Data: 11/12/2025 17:15:46-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

Prof. Dr. João Lucas Campos de Oliveira

Presidente da Banca – Orientador

PPGENF/UFRGS

Documento assinado digitalmente  
 **ANA MARIA MULLER DE MAGALHAES**  
Data: 11/12/2025 17:26:46-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

Profa. Dra. Ana Maria Muller de Magalhães

Membro da banca

PPGENF/UFRGS

Documento assinado digitalmente  
 **DANIELLE FABIANA CUCOLO NAGLIATE**  
Data: 12/12/2025 14:22:44-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

Profa. Dra. Danielle Fabiana Cucolo

Membro da banca

PUC-Campinas

Documento assinado digitalmente  
 **RENATA CRISTINA GASPARINO**  
Data: 15/12/2025 12:03:42-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

Profa. Dra. Renata Cristina Gasparino

Membro da banca

UNICAMP

## AGRADECIMENTOS

É impossível voltar o olhar ao passado sem reconhecer a relevância de inúmeras pessoas que, de forma singular, contribuíram para a concretização desta jornada que foi o Doutorado. Assim, manifesto minha mais profunda gratidão:

À minha família, alicerce de todas as minhas conquistas, pelo incentivo constante aos estudos, pela dedicação incondicional, pela educação primorosa e pelos valores, ensinamentos e exemplos que moldaram quem sou. Minha eterna gratidão à minha mãe, Denise Hertzog, aos meus avós Onira e Eliseu Hertzog, ao meu irmão Rizzieri Hertzog, e aos meus dindos Patrícia e Alberi Witt, por representarem o significado mais genuíno de amor e apoio.

Ao meu companheiro de vida, Arthur Calesso, pelo estímulo diário, pela paciência diante das minhas ausências e por estar sempre ao meu lado na realização de meus sonhos. Ao longo desses doze anos, crescemos e amadurecemos juntos; sabes que o nosso futuro é uma das maiores motivações que me impulsionam a seguir. Tornaste cada etapa deste percurso mais leve e plena de sentido.

Ao professor João Lucas Campos de Oliveira, meu orientador, expressão da escolha mais acertada ao ingressar neste Programa, registro minha admiração e sincera gratidão pela dedicação incansável, pela empatia, pela generosidade e pela orientação precisa. Sua condução serena e comprometida tornou o doutoramento um caminho leve a ser percorrido, culminando na conclusão deste trabalho antes do previsto. Agradeço pelas oportunidades concedidas, pela partilha do conhecimento e pelo exemplo inspirador de profissionalismo e humanidade.

À banca examinadora, composta por professoras cujas trajetórias admiro profundamente, agradeço pela leitura atenta, pelas valiosas contribuições e pela disponibilidade em compartilhar saberes que enriqueceram este trabalho.

Aos bolsistas de iniciação científica Bárbara e Handyer, agradeço pela colaboração, empenho e auxílio essencial na concretização deste sonho.

Aos colegas do Programa, pela convivência enriquecedora, pela parceria e pelas trocas que tornaram a caminhada mais leve e plural. Cada um de vocês, com sua personalidade e campo de saber, contribuiu para uma experiência acadêmica repleta de aprendizado e amizade.

Às amigas Luana Alves, Caroline Menezes e Priscila Consul, pela escuta paciente, pela presença constante e por partilharem comigo as inquietações e alegrias dessa trajetória. É um privilégio tê-las como amigas em minha vida.

À Débora Monteiro da Silva, minha eterna gratidão pelo acolhimento e incentivo desde o início da minha trajetória acadêmica. Recordo com carinho o momento em que, ainda no

segundo ano da graduação, a procurei com o edital em mãos, buscando compreender os caminhos para o mestrado e o doutorado. Naquele tempo, era minha coordenadora; hoje, é uma amiga, mentora e inspiração constante.

A Rudinei Bittencourt e Jaqueline Fonseca, pelo estímulo, pela confiança em meu potencial e pelos exemplos de liderança que ampliaram meu olhar e contribuíram decisivamente para meu crescimento profissional.

Por fim, agradeço a Deus, presença constante em cada passo, pela oportunidade de realizar o Doutorado em uma universidade pública e de excelência, e por colocar em meu caminho pessoas que me inspiram, fortalecem e renovam diariamente meu propósito profissional.

*“Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder”.*

**Eclesiastes 9:10**

## RESUMO

**Introdução:** O ambiente de trabalho da enfermagem é definido pelas condições laborais e relacionais que tornam mais fácil ou desafiadora a prestação de cuidados, a organização do trabalho e a qualidade da assistência. Determinados elementos do ambiente laboral, como por exemplo, carga de trabalho, proporção paciente/profissional, nível de capacitação do pessoal de enfermagem, índice de rotatividade de trabalhadores, além das chamadas *soft skills*, como comunicação, trabalho em equipe e liderança, influenciam no produto do cuidado de enfermagem. Compreender como elementos do ambiente laboral podem predizer a entrega (des)qualificada de cuidados de enfermagem é crucial para implementar estratégias que promovam uma prática profissional de excelência, sustentada por um ambiente de trabalho salutar e profícuo. **Objetivo:** Avaliar a influência das características do ambiente da prática de enfermagem na qualidade do produto do cuidado. **Método:** Estudo de método misto, de delineamento explanatório sequencial e atribuição de peso quantitativa. Os participantes do estudo foram 118 enfermeiros assistenciais de unidades de internação e de terapia intensiva adulto de quatro hospitais pertencentes a um complexo hospitalar de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, nominados nesta pesquisa como Hospital A, B, C e D. Na primeira fase, quantitativa e prioritária, foi realizada uma pesquisa transversal, sendo aplicado três instrumentos: 1) Questionário de caracterização dos participantes e preditores de qualidade do cuidado; 2) Escala Ambiente de Trabalho da Prática de Enfermagem (PESNWI) e 3) Avaliação do Produto do Cuidar em Enfermagem (APROCENF). A parcela de extração de variáveis preditoras da qualidade e o APROCENF foram aplicados em cinco turnos de trabalho (n=590), já o PESNWI, uma única vez a cada enfermeiro. Aos dados tabulados, foi aplicada análise estatística descritiva e inferencial, além de um modelo de Regressão Linear Multivariada. A variável dependente foi a qualidade do produto do cuidado de enfermagem estratificada, relacionada às características do ambiente da prática profissional. Por meio de procedimento de conexão, o estudo avançou à etapa qualitativa, secundária. Esta ocorreu por meio de entrevistas guiadas diretamente pelos dados estatísticos de maior interesse para compreensão mais aprofundada, identificados na primeira etapa. Por fim, foi realizada análise integrativa dos dados quantitativos e qualitativos, por meio de interpretações, metainferências e *joint displays*. Os princípios éticos foram respeitados, levando-se em consideração as determinações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do complexo hospitalar (Parecer 7.018.796/2024). **Resultados:** Os resultados foram descritos em dois artigos científicos. Os enfermeiros apresentaram elevados níveis de satisfação com o trabalho ( $8,23 \pm 1,63$ ) e com a profissão ( $8,80 \pm 1,39$ ), além de predominância de avaliações positivas da qualidade do cuidado (72% “bom” ou “ótimo”). Houve variações significativas entre os hospitais quanto ao ambiente de prática e ao produto do cuidado ( $p=0,011$ ). O hospital “A” destacou-se em liderança e suporte dos supervisores ( $3,61 \pm 0,39$ ), o “C” apresentou piores escores em suficiência de equipe ( $2,32 \pm 0,98$ ) e escuta institucional ( $2,18 \pm 0,87$ ). Já o hospital “B” obteve melhor escore médio global do APROCENF ( $27,5 \pm 2,1$ ). Identificaram-se correlações negativas entre o escore APROCENF e o número de leitos ( $r=-0,339$ ;  $p<0,001$ ) e positivas com recursos materiais disponíveis ( $r_s=0,239$ ;  $p=0,009$ ) e integridade dos registros de enfermagem ( $r_s=0,251$ ;  $p=0,006$ ). Escores mais elevados do produto do cuidado foram observados entre enfermeiros de unidades críticas, formados em instituições públicas e que consideravam o dimensionamento do pessoal adequado ( $p<0,05$ ). A análise qualitativa confirmou que sobrecarga, escassez de recursos e comunicação fragmentada comprometem a assistência, enquanto liderança de apoio, comunicação efetiva e valorização profissional fortalecem o ambiente laboral e a qualidade do cuidado. **Conclusão:** A qualidade do produto do cuidado de enfermagem é influenciada pelas condições do ambiente de prática profissional. Ambientes que oferecem liderança de apoio, comunicação efetiva, suficiência de recursos humanos e materiais, e processos organizacionais



consistentes tendem a gerar avaliações mais positivas do cuidado. Assim, o fortalecimento das condições laborais, do dimensionamento adequado das equipes e das práticas de gestão e registro assistencial configuram-se como conjunto estratégico para aprimorar a qualidade e a segurança do cuidado de enfermagem nos contextos hospitalares.

**Descritores:** Ambiente de Trabalho; Gestão da Qualidade; Qualidade da Assistência à Saúde; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem; Pesquisa em Administração de Enfermagem.

## ABSTRACT

**Introduction:** The nursing work environment is defined by the labor and relational conditions that make the provision of care, work organization, and quality of care easier or more challenging. Certain elements of the work environment, such as workload, patient/professional ratio, level of training of nursing staff, worker turnover rate, as well as so-called soft skills, such as communication, teamwork, and leadership, influence the outcome of nursing care. Understanding how elements of the work environment can predict the (un)qualified delivery of nursing care is crucial for implementing strategies that promote excellent professional practice, supported by a healthy and productive work environment. **Objective:** To evaluate the influence of the characteristics of the nursing practice environment on the quality of the care outcome. **Method:** Mixed-methods study, with a sequential explanatory design and quantitative weighting. The study participants were 118 nursing assistants from inpatient and adult intensive care units of four hospitals belonging to a hospital complex in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, designated in this research as Hospital A, B, C, and D. In the first, quantitative and priority phase, a cross-sectional study was conducted, using three instruments: 1) Questionnaire characterizing participants and predictors of quality of care; 2) Nursing Practice Workplace Environment Scale (PESNWI); and 3) Assessment of the Product of Nursing Care (APROCENF). The extraction of predictor variables for quality and the APROCENF were applied in five work shifts ( $n=590$ ), while the PESNWI was applied only once to each nurse. Descriptive and inferential statistical analysis, as well as a Multivariate Linear Regression model, were applied to the tabulated data. The dependent variable was the quality of the nursing care product stratified, related to the characteristics of the professional practice environment. Through a connection procedure, the study advanced to the secondary qualitative stage. This occurred through interviews guided directly by the statistical data of greatest interest for a deeper understanding, identified in the first stage. Finally, an integrative analysis of quantitative and qualitative data was performed, through interpretations, meta-inferences, and joint displays. Ethical principles were respected, taking into account the determinations of Resolution No. 466/2012 of the National Health Council. **Results:** The results were described in two scientific articles. Nurses presented high levels of job satisfaction ( $8.23 \pm 1.63$ ) and satisfaction with the profession ( $8.80 \pm 1.39$ ), in addition to a predominance of positive evaluations of the quality of care (72% “good” or “excellent”). There were significant variations among the hospitals regarding the practice environment and the product of care ( $p=0.011$ ). Hospital “A” stood out in leadership and supervisory support ( $3.61 \pm 0.39$ ), while “C” had the worst scores in staff sufficiency ( $2.32 \pm 0.98$ ) and institutional listening ( $2.18 \pm 0.87$ ). Hospital “B” obtained the best overall average APROCENF score ( $27.5 \pm 2.1$ ). Negative correlations were identified between the APROCENF score and the number of beds ( $r=-0.339$ ;  $p<0.001$ ), and positive correlations were found with available material resources ( $r_s=0.239$ ;  $p=0.009$ ) and the integrity of nursing records ( $r_s=0.251$ ;  $p=0.006$ ). Higher scores for the product of care were observed among critical care nurses trained in public institutions who considered staffing levels adequate ( $p<0.05$ ). Qualitative analysis confirmed that overload, resource scarcity, and fragmented communication compromise care, while supportive leadership, effective communication, and professional recognition strengthen the work environment and the quality of care. **Conclusion:** The quality of the nursing care product is influenced by the conditions of the professional practice environment. Environments that offer supportive leadership, effective communication, sufficient human and material resources, and consistent organizational processes tend to generate more positive evaluations of care. Thus, strengthening working conditions, adequate staffing levels, and management and care record-keeping practices constitute a strategic set to improve the quality and safety of nursing care in hospital settings. **Keywords:** Work Environment; Quality Management; Quality of Health Care; Nursing Care; Nursing; Nursing Administration Research.

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ANVISA   | Agência Nacional de Vigilância Sanitária                                      |
| APROCENF | – Avaliação do Produto do Cuidar em Enfermagem                                |
| CEP      | – Comitê de Ética em Pesquisa                                                 |
| COFEN    | Conselho Federal de Enfermagem                                                |
| COMPESQ  | – Comissão de Pesquisa                                                        |
| VIF      | Fator de Inflação da Variância                                                |
| MS       | – Ministério da Saúde                                                         |
| OMS      | – Organização Mundial da Saúde                                                |
| ONA      | – Organização Nacional de Acreditação                                         |
| PES      | – <i>Practice Environment Scale</i>                                           |
| PESNWI   | – <i>Practice Environment Scale of Nursing Work Index</i>                     |
| PIP      | – <i>Pillar Integration Process</i>                                           |
| PNSP     | – Programa Nacional de Segurança do Paciente                                  |
| RDC      | Resolução da Diretoria Colegiada                                              |
| SCPA     | – Santa Casa de Porto Alegre                                                  |
| SPSS     | – <i>Software Statistical Package for the Social Sciences</i>                 |
| STROBE   | – <i>Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology</i> |
| SUS      | – Sistema Único de Saúde                                                      |
| TCLE     | – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido                                  |
| UFRGS    | – Universidade Federal do Rio Grande do Sul                                   |
| UI       | Unidade de Internação                                                         |
| UTI      | – Unidade de Terapia Intensiva                                                |
| WinPEPI  | <i>Programs for Epidemiologists for Windows</i>                               |

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1</b> – Fluxograma representativo do estudo explicitando o desenho explanatório sequencial..... | 40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## SUMÁRIO

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO</b>                                                                    | <b>14</b> |
| <b>2 OBJETIVOS</b>                                                                     | <b>17</b> |
| 2.1 OBJETIVO GERAL                                                                     | 17        |
| 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                              | 17        |
| <b>3 REVISÃO DA LITERATURA</b>                                                         | <b>18</b> |
| 3.1 GESTÃO DO CUIDADO E O PRODUTO DO CUIDAR EM ENFERMAGEM                              | 18        |
| 3.2 QUALIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO HOSPITALAR                          | 20        |
| 3.3 AMBIENTE DA PRÁTICA PROFISSIONAL: REFLEXOS NA QUALIDADE DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM | 24        |
| <b>4 MÉTODO</b>                                                                        | <b>30</b> |
| 4.1 DELINEAMENTO DE ESTUDO                                                             | 30        |
| 4.2 CENÁRIO DE ESTUDO                                                                  | 31        |
| 4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA                                                                | 32        |
| 4.4 COLETA DE DADOS                                                                    | 32        |
| 4.4.1 Coleta de dados - Etapa quantitativa                                             | 32        |
| 4.4.2 Coleta de dados - Etapa qualitativa                                              | 39        |
| 4.5 ANÁLISE DOS DADOS                                                                  | 40        |
| 4.5.1 Análise de dados - Etapa quantitativa                                            | 40        |
| 4.5.2 Análise de dados - Etapa qualitativa                                             | 40        |
| 4.5.3 Análise integrada                                                                | 41        |
| 4.6 ASPECTOS ÉTICOS                                                                    | 42        |
| <b>5 RESULTADOS E DISCUSSÃO</b>                                                        | <b>44</b> |
| 5.1 ARTIGO I                                                                           | 45        |
| 5.2 ARTIGO II                                                                          | 65        |

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6 CONCLUSÃO GERAL</b>                                                                                      | <b>45</b> |
| <b>REFERÊNCIAS</b>                                                                                            | <b>47</b> |
| <b>ANEXO A - ESCALA AMBIENTE DE TRABALHO DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM - PES-NWI</b>                               | <b>58</b> |
| <b>ANEXO B - AVALIAÇÃO DO PRODUTO DO CUIDAR EM ENFERMAGEM - APROCENF</b>                                      | <b>60</b> |
| <b>ANEXO C - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA</b>                                                       | <b>62</b> |
| <b>APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES E DOS PREDITORES DE QUALIDADE DO CUIDADO</b> | <b>72</b> |
| <b>APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ETAPA QUANTITATIVA</b>                           | <b>75</b> |
| <b>APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ETAPA QUALITATIVA</b>                            | <b>77</b> |
| <b>APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA</b>                                                    | <b>79</b> |
| <b>APÊNDICE E - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE ÔNUS À INSTITUIÇÃO</b>                                               | <b>81</b> |
| <b>APÊNDICE F – DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE DO PARTICIPANTE DA PESQUISA</b>                               | <b>82</b> |
| <b>APÊNDICE G – DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E/OU CONSTITUIÇÃO DE BANCO DE DADOS</b>                              | <b>83</b> |
| <b>APÊNDICE H - PROCESSO DE CONSENTIMENTO/ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO</b>                                | <b>85</b> |
| <b>APÊNDICE I – ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELO RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO/LOCAL DA PESQUISA</b>    | <b>87</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

Os ambientes de trabalho da enfermagem são constituídos por características que favorecem ou dificultam a prestação de cuidados, e a governança dos enfermeiros na gestão assistencial e dos recursos envolvidos. Características como a relação entre médico e enfermeiro, a liderança de enfermagem e adequação recursos humanos são elementos constituintes do ambiente de prática de enfermagem (SIMONETTI; AIKEN; LAKE, 2023). Portanto, ambientes de trabalho positivos levam tanto a melhores resultados clínico-assistenciais, como também organizacionais (GEA-CABALLERO et al., 2021; SIMONETTI; AIKEN; LAKE, 2023).

O ambiente de trabalho da enfermagem influencia na prática assistencial e na qualidade do cuidado, podendo ser impactado pelo conhecimento dos profissionais, pelos recursos disponíveis e pelo contexto cultural da instituição/serviço em que os cuidados de enfermagem são prestados (FU et al., 2021; GRANADOS-PLAZA et al., 2021; SKELA-SAVIC et al., 2023). Neste aspecto, ao avaliar positivamente o ambiente de prática profissional, trabalhadores de enfermagem tendem a referir menos razões para omitir cuidados, além de avaliar mais positivamente o clima de segurança do paciente e também a sua própria satisfação com o trabalho (DUTRA; GUIRARDELLO, 2021).

Evidências recentes apontam uma relação diretamente proporcional no reconhecimento de fundamentos organizacionais que apoiam a qualidade dos cuidados de enfermagem por enfermeiros com a melhor avaliação destes mesmos sujeitos sobre a entrega do cuidado produzido (OCKERBY et al., 2023). Isso é relevante porque, há mais de uma década, pesquisadores afirmaram que quando enfermeiros referem (ou seja, opinam) que a qualidade do cuidado produzido na sua unidade é boa, a chance disso ser confirmado por outras medidas, como indicadores assistenciais, é alta (MCHUGH; STIMPFEL, 2012).

Determinados preditores do ambiente laboral, como por exemplo, carga de trabalho, proporção paciente/enfermeiro, nível de capacitação do pessoal de enfermagem, índice de rotatividade de enfermeiros, além das chamadas *soft skills*, como comunicação, trabalho em equipe e liderança, influenciam no produto do cuidado de enfermagem (GRANADOS-PLAZA et al., 2021; JESUS; BALSANELLI, 2023).

O produto do cuidado de enfermagem pode ser compreendido como o resultado da interação entre fatores estruturais (capital humano e serviços de suporte) e métodos de organização do trabalho (planejamento assistencial, atenção ao paciente/família e interação

multidisciplinar) que intervêm no processo de cuidar. Quanto mais favorável for o alinhamento entre esses fatores e métodos, melhor será o produto do cuidado (CUCOLO; PERROCA, 2017).

É inegável que o produto do cuidado não é dissociado do ambiente de trabalho em que ele está inserido, uma vez que o ambiente de trabalho não apenas molda as interações entre os profissionais de saúde, mas também influencia diretamente a capacidade de fornecer atendimento empático, coordenado e de alta qualidade. Assim, para alcançar um cuidado verdadeiramente excelente, é essencial cultivar ambientes de trabalho que promovam a colaboração, ofereçam recursos adequados e apoiem o bem-estar dos profissionais de saúde, inclusive - e talvez principalmente - os trabalhadores de enfermagem (GEA-CABALLERO et al., 2021; SIMONETTI; AIKEN; LAKE, 2023).

A consciência dos fatores que influenciam o ambiente de prática dos profissionais de enfermagem pode ser usada como uma ferramenta para avaliar e melhorar o ambiente de trabalho atual, podendo contribuir para a prática e qualidade assistencial (HOEVE; DRENT; KASTERMANS, 2023). Entretanto, pesquisas capazes de identificar com profundidade elementos do ambiente da prática de enfermagem que repercutem ou expliquem a qualidade do produto do cuidado não são tão comuns como aquelas que “simplesmente” diagnosticam o ambiente de trabalho, ao menos na América-Latina (RIBOLDI et al., 2021).

As lideranças de enfermagem desempenham um papel importante no estabelecimento de melhores ambientes de trabalho para os enfermeiros, propondo e estabelecendo melhorias nos processos de cuidado e de gestão (PAGUIO; YU; SU, 2020; GEA-CABALLERO et al., 2021). Concorde com essa alusão estudo transversal realizado com 1.773 enfermeiros de em cinco hospitais brasileiros que avaliou estratégias a serem priorizadas para o alcance de melhores resultados na prática de enfermagem. Evidenciou-se que as características do ambiente de prática profissional que mais contribuem para alcançar melhores resultados incluem a capacidade do enfermeiro gestor, a liderança e o apoio organizacional aos enfermeiros, a adequação de pessoal e recursos e as relações profissionais entre enfermeiro e médico (GASPARINO et al., 2021). Todavia, são poucos os estudos que comparam o impacto potencial das diversas características organizacionais do ambiente de trabalho hospitalar no serviço de enfermagem (FU et al., 2021).

Já em estudo realizado com o objetivo investigar o impacto do ambiente de trabalho da enfermagem na segurança dos pacientes em hospitais da Arábia Saudita, evidenciou-se que os fatores do ambiente de trabalho da enfermagem, especialmente participação, gestão e liderança, cuidados de enfermagem, relações interdisciplinares e a disponibilidade de recursos, são fatores que interferem na qualidade assistencial e segurança dos pacientes (AL-DOSSARY, 2022).



A qualidade do cuidado de enfermagem é uma preocupação central na dinâmica dos serviços de saúde e diversos fatores podem influenciá-la. Trata-se de um componente fundamental na promoção do bem-estar dos pacientes e no alcance de resultados positivos às organizações (SIMONETTI; AIKEN; LAKE, 2023). Contudo, conforme exposto, essa qualidade não é um resultado isolado, mas sim uma interseção complexa de fatores multifacetados. Nesse contexto, a atenção aos preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem torna-se imperativa porque isso pode explicar melhor como elementos relacionais das equipes, processuais do trabalho e os recursos disponíveis irão implicar no cuidado entregue ao paciente.

A avaliação da qualidade do produto do cuidado de enfermagem, especialmente quando relacionada ao ambiente da prática profissional, é de extrema importância para garantir a entrega de uma assistência eficaz e segura. A qualidade do cuidado de enfermagem não apenas afeta diretamente a saúde e o bem-estar dos pacientes, mas também influencia a satisfação dos profissionais de enfermagem e a eficácia geral do sistema de saúde (SIMONETTI; AIKEN; LAKE, 2023; FU et al., 2021).

Compreender como elementos do ambiente laboral impactam na entrega de cuidados de enfermagem é crucial para implementar estratégias eficazes que promovam uma prática profissional de excelência, pautada na execução de uma assistência segura, eficaz e centrada no paciente. Ao delinear e analisar os preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem associados ao ambiente de trabalho, esta pesquisa busca contribuir para a melhoria contínua da qualidade do cuidado, vinculada a ambientes de atuação profissional salutar e profícuos, considerando não apenas os fatores estruturais e organizacionais, mas também a percepção dos enfermeiros acerca da influência desses fatores no ambiente da prática profissional e nos resultados assistenciais.

Com base nessa construção teórica, tem-se a seguinte hipótese: quanto melhor for o ambiente de trabalho melhor é a qualidade do produto do cuidado de enfermagem. O estudo se propõe a responder a seguinte questão de pesquisa: Quais são os preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem relacionados ao ambiente da prática profissional?

## **2 OBJETIVOS**

### **2.1 OBJETIVO GERAL**

Avaliar a influência das características do ambiente da prática de enfermagem na qualidade do produto do cuidado.

### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- a) Caracterizar os enfermeiros quanto aos fatores sociodemográficos, de formação e laborais;
- b) Avaliar o produto do cuidado de enfermagem hospitalar;
- c) Avaliar o ambiente da prática profissional de enfermagem;
- d) Verificar a correlação de variáveis potencialmente preditoras da qualidade do produto do cuidado, correspondentes ao ambiente da prática de enfermagem;
- e) Conhecer a percepção de enfermeiros acerca dos fatores do seu ambiente de prática profissional que influenciam na qualidade do produto do cuidado;

### 3 REVISÃO DA LITERATURA

Com a finalidade de fundamentar esta proposta de estudo, a revisão de literatura segue subdividida em três temas centrais, quais sejam: gestão do cuidado e o produto do cuidar em enfermagem, qualidade assistencial no ambiente hospitalar e ambiente da prática profissional na qualidade dos cuidados de enfermagem.

#### 3.1 GESTÃO DO CUIDADO E O PRODUTO DO CUIDAR EM ENFERMAGEM

A ação gerencial é uma dimensão constituinte do processo de trabalho do enfermeiro (SILVA et al., 2022). É basilar para a eficácia na assistência de enfermagem, sendo indispensável para a condução do trabalho em equipe e dos processos laborais, o que requer dos gestores competências e habilidades, tais como comunicação, tomada de decisão, liderança, gestão de pessoas e de recursos materiais e trabalho em equipe (OFEI; PAARIMA; BARNES, 2020; PALHANO et al., 2020; MENESES; CUNHA, 2022; ALILYYAN et al., 2024).

Gestão e gerenciamento/gerência de enfermagem não são conceitos necessariamente sinônimos porque o primeiro se relaciona a liderança estratégica dos enfermeiros nos serviços de saúde voltada para a ampla mobilização de recursos para garantir seu funcionamento. Por sua vez, a gerência ou gerenciamento em enfermagem enfatiza a adoção de estratégias locais e em rede, voltada para a organização do setor de atuação, ocorre pela mobilização de competências de caráter essencialmente estratégico-administrativo. Apesar disso, tanto a gestão como a gerência em enfermagem possuem convergência no sentido de atribuir melhores condições para a execução do cuidado (BARROS et al., 2023). Considerando esta convergência e complementaridade, este estudo tratará os termos como equivalentes.

Os cuidados de enfermagem desempenham um papel fundamental na promoção do bem-estar do paciente e na otimização do produto do cuidado (HENDY et al., 2024). Cuidar é uma parte e um aspecto importante da prestação de serviços de enfermagem, sendo a essência da profissão. Nessa seara, os enfermeiros detêm a responsabilidade de desenvolver e melhorar os serviços de enfermagem através da qualidade de cuidado prestado, visto que são os responsáveis pelo planejamento e gestão desta atividade (HARYANI, 2019).

Os enfermeiros executam um papel determinante para a prestação dos cuidados, para tanto, este profissional carece dispor de habilidades e competências inerentes a sua prática laboral (PAGE; HALCOMB; SIM, 2021). Como líder do processo de cuidado, na enfermagem, a liderança está vinculada às atribuições do enfermeiro (OLIVEIRA et al., 2020). Estudo

multicêntrico realizado com enfermeiros evidencia que o estilo de liderança adotado pelos enfermeiros apresenta influência no contexto organizacional, denota-se o impacto dessa competência na equipe de enfermagem, podendo melhorar o contexto organizacional e o produto do cuidado entregue aos pacientes (FIORINI et al., 2022).

A gestão do cuidado em enfermagem envolve a coordenação e organização das atividades da equipe com o objetivo de proporcionar cuidados de qualidade aos pacientes (MARCOTTE; LIAO, 2020; DOHERTY et al., 2022; SILVA et al., 2022). Isso inclui o planejamento, implementação, avaliação e aprimoramento contínuo dos processos de cuidado. A gestão eficaz do cuidado requer uma abordagem holística que considere as necessidades físicas, emocionais e sociais dos pacientes, além de promover a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe (DOHERTY et al., 2022; SILVA et al., 2022).

Espera-se que a produção do cuidado ocorra em resposta às necessidades de saúde dos indivíduos, uma vez que seu produto se manifesta em consequência de ações que são consumidas no momento em que a assistência é prestada, de forma indissociável (FERREIRA; DALL'AGNOL; PORTO, 2016). Por este motivo, a avaliação do produto do cuidado é relevante, pois viabiliza dar assertividade na alocação de recursos e disposição de processos/tarefas, a fim de maximizar potencialidades e atenuar fragilidades que são expressas no ato concomitante de produzir/consumir cuidado em enfermagem (HALL et al., 2012; CHOTOLLI; CUCOLO; PERROCA, 2018; PARREIRA et al., 2021).

A gestão do cuidado e o produto do cuidar em enfermagem são conceitos fundamentais que desempenham um papel crucial na promoção da qualidade e eficácia dos serviços de saúde prestados aos pacientes. Isso inclui o planejamento de cuidados individualizados, a implementação de intervenções baseadas em evidências, a avaliação contínua dos resultados e a promoção da comunicação interprofissional (FERREIRA; DALL'AGNOL; PORTO, 2016).

A interação entre gestão do cuidado e produto do cuidar é essencial para garantir a assistência de enfermagem de alta qualidade, pois permite às lideranças de enfermagem avaliar a eficiência e a eficácia do processo produtivo, contribuindo nas decisões gerenciais e assistenciais (CUCOLO; PERROCA, 2017). Neste contexto, o conceito de "produto do cuidar em enfermagem" emerge como uma abordagem que busca avaliar o impacto e a efetividade das práticas de enfermagem (CUCOLO; PERROCA, 2017).

Tal mensuração pode ser realizada através da utilização do instrumento intitulado "Avaliação do Produto do Cuidar em Enfermagem" (APROCENF) que foi desenvolvido e validado para classificar o produto gerado ao final do turno de trabalho da enfermagem

permitindo também verificar os fatores que apresentam criticidade nessa produção (CUCOLO; PERROCA, 2015).

O APROCENF possui como construto os fatores estruturais e métodos de organização do trabalho e engloba quatro categorias da gestão do cuidado do enfermeiro: o planejamento, a intervenção e a avaliação do cuidado; o dimensionamento e qualificação da equipe de enfermagem; os recursos necessários para prestar assistência; e a interação multiprofissional (CUCOLO; PERROCA, 2015; CUCOLO; PERROCA, 2017). Essa ferramenta permite reconhecer elementos críticos no sistema de cuidados de enfermagem que podem afetar o produto entregue ao final do plantão, classificado em: ruim, regular, bom ou ótimo (CUCOLO; PERROCA, 2017).

Diante das variadas demandas requeridas ao enfermeiro na gestão do cuidado, o APROCENF pode contribuir no reconhecimento dos riscos presentes no ambiente de prática profissional (tais como recursos disponíveis, formação contínua e colaboração em equipe), no planejamento e avaliação do cuidado, na atenção dispensada ao paciente e familiar e na redução de incidentes percebidos pelos enfermeiros a partir da dinâmica de trabalho (CUCOLO; PERROCA, 2019).

A avaliação contínua do produto do cuidar com a utilização de instrumentos como o APROCENF, pode fornecer informações valiosas para o aprimoramento da gestão do cuidado. Por meio da análise dos resultados obtidos, os enfermeiros gestores podem identificar áreas de melhoria na prestação de cuidados, desenvolver estratégias de intervenção e monitorar o progresso ao longo do tempo (CUCOLO; PERROCA, 2017).

A gestão do cuidado e o produto do cuidar em enfermagem são conceitos inter-relacionados que desempenham um papel vital na promoção da qualidade e eficácia dos cuidados de enfermagem. Uma abordagem integrada que enfatize a coordenação eficaz da equipe, a implementação de práticas baseadas em evidências e a avaliação contínua dos resultados é essencial para garantir a entrega de uma assistência qualificada.

### 3.2 QUALIDADE DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NO CONTEXTO HOSPITALAR

Qualidade é um conceito polissêmico. Usualmente, se relaciona com o alcance de padrões desejáveis e o atendimento a determinados requisitos/atributos, que conformam os padrões. Na saúde, os atributos da qualidade podem ser compreendidos pelo referencial bem consolidado de Donabedian, a saber: eficácia, efetividade, eficiência, otimização,

aceitabilidade, legitimidade e equidade (DONABEDIAN, 1990). Outra concepção posiciona a qualidade do cuidado como um produto da aplicação do conhecimento científico e das tecnologias de saúde disponíveis, utilizadas em conjunto no atendimento ao paciente (MARTINS, 2019).

A **eficácia** na área da saúde é mensurada através do benefício produzido por sua aplicação, sob condições ideais, aos problemas dos indivíduos de uma população. O conceito de efetividade é representado pela melhoria percebida no estado de saúde de uma população quando uma tecnologia é aplicada a um problema de saúde em situações reais (DONABEDIAN, 1990).

Já a **eficiência** é uma avaliação que confronta os recursos empregados com os resultados alcançados na utilização de uma tecnologia ou serviço de saúde. Essa eficiência é determinada por meio de análises de custo-benefício, custo-efetividade e custo-utilidade, que são definidas dentro do campo da avaliação econômica. Isso é feito comparando duas alternativas tecnológicas usadas para resolver ou reduzir um problema de saúde em uma população (DONABEDIAN, 1990).

O princípio da **otimização** consiste em reduzir o tempo dedicado a tarefas dispensáveis e potencializar o tempo investindo nas atividades prioritárias. O conceito de **aceitabilidade** na qualidade relaciona-se à autonomia do paciente e a sua própria expectativa sobre o atendimento (DONABEDIAN, 1990).

A **legitimidade** é alcançada quando a qualidade no serviço permite que a instituição se torne uma referência tanto para quem nela atua quanto para a sociedade. O último pilar, **equidade**, está relacionado à manutenção da qualidade na prestação do atendimento assistencial para todos os indivíduos, sem distinções (DONABEDIAN, 1990).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) avançou nestes atributos, incluindo a segurança como um pilar/atributo essencial da qualidade na saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).

A qualidade dos cuidados é um tema de significativa importância no âmbito da enfermagem, tendo a enfermeira Florence Nightingale como precursora nessa área. Ela se destacou ao abordar o aprimoramento da qualidade na prestação de serviços de saúde durante a guerra da Criméia em 1855, concebendo métodos assistenciais que aprimoraram sobremaneira o zelo dispensado aos combatentes feridos (BELLUCCI; MATSUDA, 2011; RIEGEL et al., 2021).

Internacionalmente, nos anos de 1980, hospitais e instituições de saúde introduziram programas contínuos com o propósito de assegurar a qualidade. Esses programas tornaram-se

requisitos para o reembolso de serviços e para a obtenção de acreditação pela *Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations*. Os programas de garantia de qualidade transferiram à sociedade a responsabilidade pelo controle sobre parte das profissões de saúde no que compete à qualidade do atendimento e ao custo dos serviços de saúde que lhes eram ofertados (SMELTZER et al., 2009).

No início da década de 1990, reconheceu-se a complexidade de avaliar de maneira constante e sistemática a qualidade dos cuidados, conforme definida pelas agências reguladoras. Os critérios estabelecidos para assegurar a qualidade foram percebidos como medidas para garantir apenas as expectativas mínimas, sem oferecer meios para identificar as causas dos problemas ou determinar os sistemas e processos que precisavam ser aprimorados. A busca pela melhoria contínua da qualidade foi, então, reconhecida como um método mais eficaz para aprimorar os cuidados de saúde. Em 1992, a revisão dos padrões pela *Joint Commission* passou a demandar que as organizações de saúde implementassem um programa voltado para a melhoria contínua da qualidade (SMELTZER et al., 2009).

A segurança do paciente tem sido abordada como um componente essencial da qualidade dos serviços de saúde desde o início dos anos 2000 (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013; DIZ; LUCAS, 2022). Isso porque, a segurança do paciente refere-se às atividades organizacionais que estabelecem culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes no âmbito dos cuidados de saúde que, de maneira consistente, visam reduzir os riscos e prevenir danos evitáveis aos pacientes, tornando os erros menos prováveis e mitigando o impacto na sua ocorrência (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). Ou seja, a segurança do paciente influencia diretamente na qualidade do cuidado, visto que ao expor o paciente à assistência insegura, ele não alcançará padrões plenos de qualidade assistencial.

Ofertar cuidados de qualidade e garantir a segurança do paciente são objetivos fundamentais para as instituições de saúde (ALSADAAN et al., 2023). Na atenção hospitalar, a qualidade dos cuidados está intimamente ligada à qualidade da assistência fornecida pelos profissionais que exercem suas atividades nesse cenário (KOERICH; ERDMANN; LANZONI, 2020). Todavia, apesar da influência considerável das intervenções de enfermagem na qualidade assistencial, mensurar a qualidade dos cuidados e sua repercussão no produto do cuidado dos pacientes nos sistemas de saúde segue sendo um desafio, pois o cuidado é um fenômeno essencialmente intangível (FANEH, ABU-MOGHLI, AHMAD, 2021).

Tal fato decorre dos cuidados de saúde serem uma indústria extremamente complexa e de alto risco, com potencial para erros que resultam em lesões ou mortalidade dos pacientes.

Muitos sistemas de saúde progrediram em direção a princípios de alta confiabilidade para melhorar a qualidade e a segurança (STUCKY; WYMER HOUSE, 2022). Nesse contexto, a associação de medidas de desempenho, detecção de oportunidades de melhorias e desenvolvimento de estratégias para o aumento da adesão às boas práticas em saúde são fundamentais para a otimização de resultados (HUNG, 2020; RAMIRES, 2020).

Instituições dedicadas à certificação dos serviços de saúde, tanto em âmbito nacional quanto internacional, investigam e analisam os serviços, estabelecem indicadores para sua avaliação e realizam medições e registros com o objetivo de promover reflexões e intervenções organizacionais. No contexto nacional, a Organização Nacional de Acreditação (ONA) e o Ministério da Saúde (MS) desempenham importante papel na contribuição para este processo, pois visam estabelecer padrões pré-definidos que assegurem a avaliação sistemática da qualidade dos serviços (SANTOS; SOARES, 2014).

Receber assistência qualificada e segura é um direito fundamental de cada indivíduo. Com base nessa premissa, foi criada em 2013 a Portaria nº 529/2013, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Desenvolvido pelo MS, O principal propósito deste programa é contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados assistenciais em todas as instituições de saúde em território nacional. A iniciativa mostrou-se necessária para fomentar e apoiar a incorporação de medidas voltadas para a segurança do paciente, uma prioridade evidente nas instituições de saúde (BRASIL, 2013).

O PNSP possui atrelado às suas principais atribuições a gestão e organização dos serviços de saúde, por intermédio da implantação da gestão de riscos e de Núcleos de Segurança do Paciente nas instituições de saúde. Ademais, busca o envolvimento dos pacientes e familiares em ações de segurança do paciente, objetiva a ampliação do acesso da população às informações relacionadas à segurança do paciente, produzindo e difundindo conhecimentos sobre a temática, sobretudo, na área da saúde (BRASIL, 2013).

Tal Programa reforça o impacto da segurança do paciente na qualidade da assistência de enfermagem. Mitigar riscos e danos e incorporar boas práticas favorecem a efetividade dos cuidados de enfermagem e o seu gerenciamento de forma segura. Essa melhoria depende de uma mudança de cultura dos profissionais para a segurança, uso de indicadores e da existência de um sistema de registros, alinhados à política de segurança do paciente instituída nacionalmente (OLIVEIRA et al., 2014).

Manter um cuidado de enfermagem qualificado é primordial para garantir a segurança do paciente (DARAGHMEH et al., 2024). Em uma cultura que busca constantemente aprimorar a gestão de qualidade e segurança do paciente, é um diferencial a participação ativa e o



comprometimento dos profissionais na incorporação e consolidação dos projetos integrados na prestação de cuidados (SERGIO et al., 2023).

O aprimoramento da gestão da qualidade dos cuidados de enfermagem resulta da busca contínua por processos sistemáticos e estruturados, guiados pela precisão e pela evidência de indicadores provenientes da prática, com impacto direto no paciente e nas expectativas de qualidade. Para além deste aparato técnico, no contexto da valorização das melhores práticas de enfermagem, é estratégico direcionar o foco para o aprimoramento de práticas dos profissionais, fundamentado na valorização e no desenvolvimento das competências das equipes, e, conseqüentemente, no comprometimento organizacional (SERGIO et al., 2023).

Diante do exposto, a qualidade do cuidado de enfermagem desempenha um papel central no contexto hospitalar, influenciando diretamente a experiência do paciente e os resultados clínicos. A implementação de práticas de gestão da qualidade, a promoção de uma cultura de segurança e o desenvolvimento contínuo das habilidades e competências da equipe de enfermagem são pilares fundamentais para garantir um ambiente de trabalho que viabilize a excelência nos cuidados. A atenção consciente aos protocolos, a comunicação eficaz entre profissionais e pacientes, e a busca constante por aprimoramento refletem o compromisso com a prestação de uma assistência qualificada e segura.

### 3.3 AMBIENTE DA PRÁTICA PROFISSIONAL: REFLEXOS NA QUALIDADE DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM

O ambiente de prática profissional é definido pelas condições do local de trabalho que tornam mais fácil ou desafiadora a prestação de cuidados, a organização do trabalho e a qualidade da assistência (GEA-CABALLERO et al., 2018; EL-GAZAR et al., 2024). Os aspectos favoráveis do ambiente de trabalho, que facilitam as atividades, tendem a promover um ambiente com maior engajamento dos profissionais, com autonomia, liderança e maior satisfação de quem nele labora (O'HARA et al., 2019). Por outro lado, um ambiente com atributos desfavoráveis, resulta em desmotivação, produtividade reduzida, esgotamento emocional, alta rotatividade, problemas de saúde entre os trabalhadores, além de práticas inseguras. (DORIGAN, GUIARDELLO, 2018; AMBANI, KUTNEY-LEE, LAKE, 2020; SILLERO-SILLERO, ZABALEGUI, 2020).

Nesse sentido, sabendo da importância da manutenção de um ambiente com atributos favoráveis, a Organização das Nações Unidas em um apelo global para a proteção do ambiente trás objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo eles: erradicação da pobreza; fome zero e

agricultura sustentável; saúde e bem estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia acessível e limpa; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação (PACTO GLOBAL, 2024).

Fomentar a promoção de ambientes de prática favoráveis é crucial para um processo de trabalho saudável, bem como para a qualificação dos cuidados de enfermagem (CAMPONOOGARA et al., 2022). Todavia, mesmo ambientes favoráveis/positivos à prática de enfermagem podem apresentar “resultados” ruins, como a presença da síndrome de *burnout* na equipe (FURLAN; GUIRARDELLO, 2025) o que reforça que a prática laboral de enfermagem é muito complexa. Nessa lógica, além de diversos estudos estarem sendo conduzidos com o objetivo de ratificar a relevância de um ambiente de prática favorável ao trabalho do enfermeiro (PERRUCHOUD et al., 2021; RIMAN et al., 2023; WILLIAMS et al., 2023; SOMMER, WILHELM, WAHL, 2024), os processos que intermediam a constituição deste ambiente e como ele, de fato, interfere na produção do cuidado, são relevantes.

Instituições que mantêm ambientes de trabalho favoráveis à prática da enfermagem apresentam melhores resultados, para pacientes, profissionais de saúde e a própria instituição. No que diz respeito aos pacientes, evidências mostram melhor percepção da equipe sobre a segurança da assistência prestada, menores taxas de mortalidade e complicações. No âmbito profissional, observa-se níveis mais baixos de exaustão e maior satisfação dentre a equipe de enfermagem. Para a instituição, a rotatividade de funcionários é minimizada (GASPARINO et al., 2020).

O ambiente de trabalho da enfermagem abrange aspectos físicos, organizacionais e psicossociais que influenciam a capacidade dos enfermeiros em ofertar cuidados abrangentes e de excelência (ULRICH et al., 2019 ). Investigações acerca do ambiente de prática da enfermagem surgem como uma opção para ampliar a compreensão dos fatores que influenciam a execução da prática profissional e que, por conseguinte, podem repercutir na qualidade da assistência ao paciente (MÖLLER et al., 2021).

Na década de 1980, nos Estados Unidos, surgiram os primeiros estudos sobre o ambiente da prática profissional da equipe de enfermagem. Inicialmente, o objetivo dos estudos, desenvolvidos pela *American Academy of Nursing*, era compreender o motivo para alguns hospitais conseguirem reter seus profissionais e manter um ambiente satisfatório no trabalho. Os resultados identificaram que autonomia, controle sobre o ambiente de trabalho e a

colaboração entre médicos e enfermeiros contribuem para a minimização do índice de burnout, além de aumentar a satisfação do enfermeiro com seu trabalho. Esses resultados foram replicados e hoje a designação *Magnet® Hospitals* certifica instituições de saúde com bons locais para enfermeiros atuarem (KELLY; MCHUGH; AIKEN, 2011; KUTNEY-LEE et al., 2015).

Nos últimos anos, houve um impulso na avaliação do ambiente de prática da enfermagem, através do instrumento de avaliação *Nursing Work Index*, desenvolvido nos Estados Unidos na década de 80, foi possível descrever características organizacionais hospitalares que são atrativas para os profissionais de enfermagem (MARCELINO et al., 2014). Em 2002, a sua reformulação originou a *Practice Environment Scale* (PES), fundamentado em teorias sociológicas das organizações e do trabalho (LAKE, 2002). Devido à sua solidez, validade interna e contribuição substancial para o conhecimento na área de enfermagem, a PES tem recebido recomendações e encorajamento para ser utilizada como a medida preferencial do ambiente de prática profissional pelo Fórum da Qualidade Nacional dos Estados Unidos. Além disso, foi acreditado pela *Joint Commission* como indicador da eficácia do cuidado de enfermagem (WARSHAWSKY; HAVENS, 2011).

Diversos elementos impactam no ambiente de trabalho da enfermagem, como a infraestrutura, a administração do serviço, a proporção enfermeiro-paciente, a escassez de pessoal, a carga de trabalho elevada, a colaboração e trabalho em equipe, a comunicação e a insuficiência de recursos materiais. Um cenário que está diretamente relacionado ao aumento de casos de omissão de cuidados, podendo resultar em eventos adversos. Este tema abrange uma variedade de elementos inter-relacionados que impactam a entrega dos cuidados, desde a competência técnica dos profissionais até a infraestrutura e o ambiente de trabalho (WHITE et al., 2020; DUTRA, SALLES, GUIRARDELLO, 2019; AMORIM et al.; 2022).

As condições de trabalho dos trabalhadores de enfermagem também impactam a saúde mental dos profissionais e consequentemente afetam a qualidade dos cuidados de saúde que prestam. O conjunto de demandas de trabalho e estressores aos quais estão expostos deve ser controlado e modificado para garantir um ambiente de trabalho saudável. Condições adversas têm um impacto adverso na saúde física e mental dos profissionais de saúde. A equipe de enfermagem está entre as mais afetadas e frequentemente vivencia a síndrome de *burnout* ou uma de suas diversas dimensões, incluindo exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal (ZAVALA; ZAMORA-MACORRA; ALCÁNTARA, 2022).

Nesse cenário, a escassez de pessoal de enfermagem emerge como um elemento crucial que influencia o racionamento na prestação de cuidados (CAMPBELL et al., 2020; ZHAO et

al., 2020). Compreende-se que questões ligadas à adequação do tamanho da equipe de enfermagem expõem pacientes a riscos, tais como, tratamentos inadequados, erros na assistência de enfermagem, aumento de eventos adversos e omissão na realização de cuidados (LOPES et al., 2021; DRENNAN et al., 2024). Além da dimensão quantitativa, assume-se que equipes de enfermagem melhor dimensionadas em termos de capacidade técnica e também de experiência profissional podem apresentar melhores resultados, incluindo menores taxas de absenteísmo (NWANOSIKE et al., 2025).

Melhorar a satisfação profissional dos enfermeiros é um mecanismo através do qual futuras intervenções poderão melhorar as condições de trabalho e promover uma melhor retenção dos enfermeiros (SABEI et al., 2020). A motivação, o clima organizacional e o envolvimento no trabalho estão positivamente relacionados com uma grande variedade de fatores pessoais vinculados com o trabalho (HOEVE; DRENT; KASTERMANS, 2023).

As instituições de saúde podem melhorar o ambiente de prática dos profissionais de enfermagem atentando-se aos fatores pessoais relacionados com o trabalho que influenciam na motivação e envolvimento (HOEVE; DRENT; KASTERMANS, 2023). O comportamento organizacional tem sido identificado como um fator importante na melhoria da qualidade e da segurança dos cuidados hospitalares (FU et al., 2021).

Ademais, o aperfeiçoamento e a atualização profissional do enfermeiro, também desempenham papel crucial na definição da qualidade do atendimento prestado ao paciente (DARAGHMEH et al., 2024). A qualidade e segurança assistencial são influenciadas pelo conhecimento dos profissionais, pelos recursos disponíveis e pelo contexto em que os cuidados de enfermagem são prestados. (GRANADOS-PLAZA et al., 2021; JESUS; BALSANELLI, 2023). O conhecimento do enfermeiro, guiado pela educação em enfermagem e pela experiência clínica, possibilita a pronta identificação das necessidades do paciente e fornece a perspicácia clínica para avaliar e agir sobre possíveis ameaças à qualidade e segurança (LAPIEDRA, BARRADO-NARVIÓN, BERNUÉS-OLIVÁN, 2023; STUCKY et al., 2023).

A formação sólida, a atualização constante das habilidades e o comprometimento com as melhores práticas são essenciais para assegurar que os pacientes recebam cuidados seguros e eficazes. Além disso, a capacidade de adaptação a novas tecnologias e abordagens terapêuticas é crucial para enfrentar os desafios em constante evolução na área da saúde. A atuação diferenciada da equipe de enfermagem fundamentada na educação continuada possibilita que estes profissionais otimizem sua experiência, competências e habilidades, contribuindo para a oferta de cuidados eficazes e qualificados ao paciente (KRAAIJ et al., 2022; KIM; LEE; LEE, 2022). A ausência de diligência no exercício da enfermagem acarreta

prejuízos aos protocolos assistenciais, e atenuar esse fenômeno revela-se imprescindível para preservar a integridade da segurança do paciente e aprimorar a excelência nos serviços de cuidados prestados (IMAM et al., 2023).

A comunicação eficaz entre os membros da equipe de saúde também desempenha um papel significativo na qualidade do cuidado. Uma coordenação fluida entre a equipe multiprofissional é vital para garantir que as informações relevantes sejam compartilhadas e compreendidas, evitando erros e garantindo uma abordagem integrada ao paciente (FERREIRA, 2020; FOWLER; ROBBINS; LUCERO, 2021; SILVA et al., 2022). Estudo realizado em instituição hospitalar de grande porte de São Paulo aponta a relevância da comunicação como um elemento básico na assistência ao paciente, assim como a necessidade de reduzir o ruído e incentivar a participação ativa dos colaboradores nos processos de tomada de decisão (MENEZES et al., 2022).

O ambiente de trabalho tem sido reconhecido como um determinante significativo da omissão de cuidados (CHIAPPINOTTO; COPPE; PALESE, 2023). Cuidados de enfermagem omitidos referem-se a atividades ou tarefas essenciais de enfermagem que são omitidas ou não concluídas conforme planejado durante o cuidado de um paciente (PAPATHANASIOU et al., 2024). Isso significa, que sob determinadas condições de trabalho, devido à insuficiência de recursos necessários, podem haver ocasiões em que os profissionais de enfermagem não consigam prestar assistência a todos os pacientes sob seus cuidados (CAMPBELL et al., 2020; ZHAO et al., 2020).

Esta omissão pode resultar de vários fatores, por exemplo, a sobrecarga de trabalho e os níveis inadequados de pessoal têm o potencial de impor limitações temporais e prejudicar a habilidade dos profissionais de enfermagem em executar todas as tarefas de cuidado necessárias. Da mesma forma, a comunicação deficiente e a ausência de apoio podem colaborar para falhas na prestação de cuidados (WHITE et al., 2020; PAPATHANASIOU et al., 2024). Adicionalmente, a existência de recursos tangíveis, tais como medicamentos e equipamentos operacionais, exerce influência substancial na eficácia dos cuidados (PAPATHANASIOU et al., 2024).

Revisão sistemática apontou que os cuidados de enfermagem omissos estão associados principalmente à *déficit* de quantitativo de pessoal, à desatualização profissional e aos ambientes de trabalho, com associações negativas aos resultados dos pacientes: satisfação, erros de medicação, infecções, incidentes e readmissões (STEMMER et al., 2022). Diante do exposto, sabe-se que as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem provocam repercussões no cuidado prestado. Desta forma, avaliar variáveis como ambiente de trabalho e

características organizacionais é crucial para melhorar o cenário laboral (YAHYAEI et al., 2022).

Identificar as lacunas nos cuidados de saúde pode direcionar melhorias na qualidade dos cuidados de saúde, tais como melhorar a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde, e ajudar a identificar quais iniciativas visar, todas elas fundamentais para a prestação de cuidados de alta qualidade (GROSJEAN et al., 2021). A exploração de experiências de cuidados de saúde pode fornecer informações sobre lacunas nos serviços que podem ajudar a direcionar a melhoria da qualidade, como melhorar a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde (READ et al., 2022; DANOUDIS, SOH, IANSEK, 2023).

Considera-se primordial realizar investigações para compreender as características do ambiente de prática de enfermagem em diferentes contextos de prestação de cuidados, de forma abrangente, levando em conta diferentes realidades. Acredita-se que, por meio dessas pesquisas, seja possível identificar fragilidades no ambiente laboral e oferecer *insights* para a implementação de estratégias que favoreçam a prática profissional, resultando em melhor qualidade de cuidado, satisfação profissional e contribuindo para o avanço do conhecimento nessa temática (CAMPONOGARA et al., 2022). Com base nessa premissa, vislumbra-se na literatura, a condução de pesquisas que buscam caracterizar o ambiente de trabalho dos enfermeiros e suas repercussões, com ênfase em estudos tanto nacionais quanto internacionais (BETSIU et al., 2022; MAGALHÃES et al., 2023; EL-GAZAR et al., 2024). Em suma, a análise do ambiente da prática profissional revela impactos significativos na qualidade dos cuidados de enfermagem, visto que estes são produto do próprio ambiente de produção.

A equipe de enfermagem constitui a maior parte dos profissionais atuantes em um hospital. Com um papel crucial e significativa influência nos resultados dos pacientes, faz-se necessário fornecer a esta equipe um ambiente de prática favorável para que se possa desenvolver a prática laboral com excelência. A utilização de instrumentos de avaliação, como a PES, emerge como uma ferramenta valiosa para compreender e melhorar o cenário de trabalho. Investir na otimização desses ambientes não apenas eleva a excelência no cuidado prestado, mas também contribui para a saúde e satisfação dos profissionais.

## 4 MÉTODO

### 4.1 DELINEAMENTO DE ESTUDO

Estudo de estratégia de investigação mista, com delineamento explanatório sequencial e atribuição de peso quantitativa (QUAN→qual) (CRESWELL, 2021). Este tipo de estudo é desenvolvido em duas etapas distintas, porém conectadas. A premissa deste desenho ocorre pelo início da coleta e análise de dados quantitativos e, posteriormente, sendo realizada a coleta e análise de informações qualitativas, seguida da análise final integrada. Portanto, os resultados quantitativos iniciais sustentam a coleta dos dados qualitativos, sendo esta segunda etapa concebida sobre os dados da primeira e, seus resultados ajudam a explicar os resultados quantitativos iniciais (CRESWELL, 2021).

Métodos mistos de pesquisa têm sido incentivados em virtude da complexidade e diversidade de fenômenos e problemas que as ciências enfrentam, em que a utilização de um único enfoque (*single method*), seja ele quantitativo ou qualitativo, é insuficiente para trabalhar essa complexidade (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013; OLIVEIRA, 2020; CRESWELL, 2021). Neste estudo, entende-se que os possíveis preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem são elementos complexos, que, apesar de serem passíveis de ser submetidos à mensuração enquanto variáveis potencialmente preditoras, considera-se oportuno que essa verificação vá além da métrica, já que a produção do cuidado de enfermagem trata-se de um evento dinâmico, visto que diversos são os fatores e contextos que interferem para a geração do produto final. Nesse sentido, o cuidado de enfermagem, em sua natureza, é um fenômeno complexo, da mesma forma que todos os aspectos que compactuam com ele, como quem cuida e os instrumentos necessários para a viabilização do mesmo.

A etapa quantitativa e de maior peso é oriunda de um estudo com delineamento transversal. Estudos transversais ou *surveys* são estudos de prevalência que visualizam a situação de uma determinada população em um determinado recorte no tempo, e todas as medições são realizadas sem período de segmento, fundamentais quando se quer descrever variáveis e seus padrões de distribuição e/ou associação (HULLEY et al., 2015; ROUQUAYROL; GURGEL, 2017). O desenho deste projeto respeitou as recomendações para estudos seccionais do *Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology* (STROBE) (ELM et al., 2007).

Para este estudo, a variável dependente/desfecho foi o produto do cuidado de enfermagem, da qual testou-se a associação com as variáveis independentes/preditores, descritas posteriormente. Na etapa qualitativa posterior e de menor peso, foi realizado um estudo exploratório--descritivo.

Essa fase teve como objetivo aprofundar a compreensão dos achados quantitativos, explorando percepções, significados e experiências dos participantes relacionadas ao fenômeno investigado. A condução do estudo qualitativo seguiu as diretrizes do *Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research* (COREQ), contemplando os domínios referentes à equipe de pesquisa, desenho do estudo e análise dos dados, conforme recomendado para estudos qualitativos com entrevistas e grupos focais. A abordagem exploratória permitiu investigar a natureza do fenômeno e os fatores a ele associados, enquanto o delineamento descritivo possibilitou detalhar, classificar e compreender as características, variações e relevância das experiências relatadas, contribuindo para a interpretação ampliada dos resultados do estudo (POLIT; BECK, 2019).

#### 4.2 CENÁRIO DE ESTUDO

O campo de estudo foram as Unidades de Internação (UI) e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para adultos dos Hospitais pertencentes ao complexo hospitalar Santa Casa de Porto Alegre (SCPA). Optou-se por realizar a coleta de dados em 4 dos Hospitais pertencentes ao complexo, a escolha entre os hospitais deu-se pelo perfil de atendimento (clínico e cirúrgico) e pelo volume de profissionais alocados. Nesta pesquisa, para apresentação dos resultados, intitularemos como Hospital A, B, C e D.

A SCPA é de um dos complexos hospitalares mais modernos do Brasil, tida como referência nacional em virtude da qualidade e segurança de sua assistência, pelo humanismo, excelência e modernidade dos processos e equipamentos. Ao todo, o complexo hospitalar conta com 1.261 leitos e 87 salas cirúrgicas, além de ambulatórios das mais diversas especialidades (SANTA CASA DE PORTO ALEGRE, 2025).

A SCPA realiza mais de seis milhões de atendimentos ao ano e é composta por nove hospitais. Dois dos Hospitais são gerais (um para atendimento de adulto e outro pediátrico). Recentemente (2023), houve a incorporação do Hospital Nora Teixeira que conta com leitos destinados a convênios e particulares e uma nova emergência destinada ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). As demais unidades hospitalares são especializadas em cardiologia, neurocirurgia, pneumologia, oncologia e transplantes. Os



hospitais pertencentes ao complexo situados em Porto Alegre são acreditados pela ONA nível III. O Hospital Dom João Becker, da cidade de Gravataí e campo de atuação profissional da pesquisadora principal deste estudo, faz parte do complexo desde 2018 e é acreditado pela ONA desde 2022 (nível I) (SANTA CASA DE PORTO ALEGRE, 2025).

#### 4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Os participantes do estudo foram enfermeiros assistenciais das UIs e UTIs adulto que atuam no cenário de pesquisa. A população é constituída por aproximadamente 215 são enfermeiros que realizam a prática assistencial nas UIs e UTIs.

Na definição da amostra, foram considerados os seguintes critérios de inclusão: atuar no cargo em tempo  $\geq$  seis meses e estar em pleno exercício profissional no período da coleta. Os critérios de exclusão foram: profissionais em afastamento laboral no período da coleta de dados e não atuar direta e rotineiramente na assistência ao paciente internado. Ambos os critérios foram adotados tanto na etapa quantitativa como qualitativa.

Por conseguinte, na etapa quantitativa, a amostra foi formada por conveniência e foi constituída por 118 enfermeiros assistenciais das UIs e UTIs dos hospitais. O cálculo do tamanho da amostra foi realizado no programa WinPEPI (*Programs for Epidemiologists for Windows*) versão 11.65 e baseado nos estudos de Chotolli, Cucolo e Perroca (2018) e Jesus e Balsanelli (2023). Para um nível de significância de 5%, poder de 80%, uma estimativa de qualidade do produto boa ou ótima em 75% e uma diferença de 20% quanto aos fatores associados, obteve-se um total mínimo 118 enfermeiros.

Já na etapa qualitativa, participaram da pesquisa 12 enfermeiros que haviam participado da primeira etapa de coleta, sendo definidas as duas unidades com piores e as duas com melhores resultados da etapa quantitativa para a realização das entrevistas. A saturação de dados norteou a decisão de que se alcançou amostragem o suficiente, sendo evidenciada por meio da repetitividade dos registros, em relação às informações coletadas nas entrevistas (POLIT; BECK, 2019).

#### 4.4 COLETA DE DADOS

##### 4.4.1 Coleta de dados - Etapa quantitativa

Na etapa quantitativa foi realizada uma pesquisa transversal. A coleta de dados quantitativos foi realizada de setembro de 2024 a fevereiro de 2025. Ao todo, 23 unidades

(voltadas para atendimento de SUS, convênios e particulares) foram investigadas (quatro UTIs sendo uma por hospital e 19 UIs sendo 3 no hospital A, 6 no B, 6 no C e 3 no D), as quais totalizavam 182 enfermeiros, população alvo do estudo. Dessa forma, foi realizada coleta de dados com enfermeiros *in loco* na instituição cenário do estudo, em local privado. A cada participante, em abordagem por conveniência, após o horário de atuação e no próprio local de trabalho, foram fornecidos três instrumentos, sendo orientado o participante quanto ao preenchimento (autorresposta), sendo eles:

1) Questionário de caracterização dos participantes e preditores de qualidade do cuidado (APÊNDICE A).

2) Escala Ambiente de Trabalho da Prática de Enfermagem - PESNWI (ANEXO A) (GASPARINO; GUIRARDELLO, 2017).

3) Avaliação do Produto do Cuidar em Enfermagem - APROCENF (ANEXO B) (CUCOLO; PERROCA, 2017).

Inicialmente, houve a aplicação de questionário de caracterização dos participantes e dos preditores de qualidade do cuidado (APÊNDICE A). Esse instrumento foi construído pela pesquisadora, enfermeira, doutoranda, supervisora de enfermagem atuante no gerenciamento em enfermagem há quatro anos, orientada por um doutor em enfermagem, pesquisador na área de estudo. O instrumento foi submetido a uma avaliação de aparência por três supervisores de enfermagem que atuam no gerenciamento há mais de três anos, aos quais consideraram o instrumento adequado e não realizaram sugestões de adequação.

O instrumento era composto por dois blocos. O primeiro, direcionado à extração das variáveis de caracterização dos enfermeiros, a saber: sexo, idade, estado civil, turno, tempo de atuação na profissão, hospital empregador, unidade de atuação, titulação e natureza da instituição que realizou graduação. Já o segundo bloco, era voltado às variáveis potencialmente preditoras da qualidade do cuidado: quantitativo de leitos da unidade, taxas de absenteísmo, necessidade de remanejo e/ou horas extras na equipe, percepção sobre a adequação do dimensionamento de profissionais, quantidade de pacientes sob responsabilidade do enfermeiro e do técnico de enfermagem, bem como o número de técnicos supervisionados por enfermeiro. Além disso, investigou-se se havia, na equipe, técnicos de enfermagem com menos de três meses de integração ao hospital e a ocorrência de eventos adversos durante o plantão. Considerou-se ainda a necessidade de acionamento do time de resposta rápida ou do intensivista para intercorrências, e a ocorrência de conflitos interpessoais na equipe. Aspectos relacionados à estrutura e à continuidade da assistência também foram contemplados, como a disponibilidade

de recursos materiais necessários à prestação do cuidado, atrasos em encaminhamentos para exames, e a qualidade das transições de cuidado — tanto na passagem de plantão quanto nas transições intersetoriais. Foram ainda avaliadas a realização adequada dos registros em prontuário e variáveis subjetivas associadas à equipe, como o nível de satisfação com o emprego e com a profissão, a intenção de desligar-se do emprego atual ou da profissão e, por fim, a autoavaliação dos profissionais quanto à qualidade do cuidado de enfermagem prestado na unidade, todas estas em escalas unidimensionais de 0 a 10. O primeiro bloco do questionário foi aplicado uma única vez neste estudo, e o segundo bloco foi coletado concomitantemente a sistemática de coleta de dados do APROCENF, descrita a seguir.

A *Practice Environment Scale of Nursing Work Index* (PESNWI) foi inicialmente proposta com base no Índice de Trabalho em Enfermagem (NWI) e foi constituída inicialmente por 65 itens com o objetivo de mensurar os atributos organizacionais no ambiente de trabalho do enfermeiro (AIKEN; PATRICIAN, 2000). Em 1981 a Academia Americana de Enfermagem desenvolveu um estudo para identificar e avaliar os *Magnet Hospitals*, assim denominados por atraírem e reterem enfermeiros (MCCLURE; POULIN; SOVIE, 1983). Estes hospitais possuíam um conjunto de características organizacionais, tais como: gestão e liderança efetiva e participativa; responsabilidade pela qualidade dos cuidados aos pacientes, tomada de decisão descentralizada, reconhecimento e autonomia profissional, prestação de contas, *staff* adequado e horários flexíveis (FERREIRA; AMENDOEIRA, 2014). O estudo evidenciou que tais características possuíam associação com a satisfação no ambiente laboral e a qualidade assistencial (MCCLURE; POULIN; SOVIE, 1983).

A PESNWI foi confeccionado levando em consideração as características dos *Magnet Hospitals*, o Índice de Trabalho de Enfermagem e os resultados da utilização deste índice para mensurar os atributos organizacionais dos hospitais, como uma medida do desempenho do cuidado de enfermagem e permitindo a classificação dos ambientes das instituições (AIKEN; PATRICIAN, 2000).

A PESNWI vem sendo utilizada em diferentes culturas e tem demonstrado propriedades de medida satisfatórias (MIHDAWI et al., 2020; YANARICO et al., 2020; LUCAS et al., 2021; AL-DOSSARY, 2022). No Brasil, ela foi adaptada e validada, sendo um instrumento válido e confiável utilizado para avaliar as características que promovem a prática profissional de enfermagem (GASPARINO; GUIRARDELLO, 2017). Nessa pesquisa, foi aplicada no primeiro momento de coleta.

A versão brasileira da PES-NWI é composta por 24 itens, distribuídos em cinco subescalas: “participação dos enfermeiros na discussão dos assuntos hospitalares” (itens 5, 13,

17, 19, 22); “adequação da equipe e de recursos” (itens 1, 7, 8, 10); “fundamentos de enfermagem voltados para a qualidade do cuidado” (itens 4, 14, 15, 18, 21, 23, 24); “habilidade, liderança e suporte dos coordenadores/supervisores de enfermagem aos enfermeiros/equipe de enfermagem” (itens 3, 6, 9, 11, 16) e relações de trabalho positivas entre médicos e enfermeiros (itens 2, 12, 20) (GASPARINO; GUIARDELLO, 2017). As opções de resposta do instrumento variam de um a quatro pontos, por meio de uma escala tipo *Likert*, sendo: Discordo totalmente (um ponto); Discordo parcialmente (dois pontos); Concordo parcialmente (três pontos) e Concordo totalmente (quatro pontos), ou seja, quanto maior a pontuação, maior a presença de características favoráveis ao desenvolvimento das atividades de enfermagem (GASPARINO; GUIARDELLO, 2017).

A partir dos escores obtidos, o ambiente de prática é classificado em três categorias: ambiente desfavorável, quando nenhuma ou apenas uma subescala apresenta média  $\geq 2,5$ ; ambiente misto, quando duas ou três subescalas apresentam média  $\geq 2,5$ ; e ambiente favorável, quando quatro ou cinco subescalas atingem média  $\geq 2,5$ , conforme preconizado na validação da versão brasileira do instrumento (GASPARINO; GUIARDELLO, 2017).

Em contrapartida, o estudo do APROCENF foi desenvolvido a partir da abordagem qualitativa por meio do uso do grupo focal. Como referencial teórico, utilizou-se a visão sistêmica e o pensamento complexo na concepção de gestão e na produção do cuidado em Enfermagem (CUCOLO; PERROCA, 2017; CUCOLO; PERROCA, 2015; CHAFFEE, MCNEILL, 2007), que percorreu três fases: 1) Geração de itens e desenvolvimento do instrumento; 2) Validação do conteúdo; 3) Análise de confiabilidade e validade do construto. A escala APROCENF (CUCOLO; PERROCA, 2017) tem seu conceito ancorado no tripé: produção do cuidado, gestão e qualidade em saúde com a combinação de fatores que poderão contribuir para a entrega do cuidado de enfermagem.

Esta escala é constituída por oito domínios, caracterizados por quatro itens em cada domínio, e respectivas definições:

1 - Planejamento da assistência de enfermagem - (1) Não avalia pacientes (enfermeiro não realiza visita); não realiza planejamento da assistência de enfermagem; a organização dos processos e da unidade é gravemente comprometida com resultados assistenciais inadequados (erros, eventos indesejados ou agravos). (2) Avalia parcialmente os pacientes e de forma indireta (coleta informações junto à equipe); realiza limitado planejamento da assistência de enfermagem; a organização dos processos e da unidade é muito comprometida e os resultados assistenciais são parcialmente adequados (até 50%). (3) Avalia pacientes com maior dependência de cuidados (visita do enfermeiro pautada nos riscos e gravidade); realiza a maior

parte do planejamento da assistência de enfermagem; a organização dos processos e da unidade pode ser levemente comprometida e os resultados assistenciais são quase totalmente adequados (75%). (4) Avalia integralmente todos os pacientes; realiza amplo planejamento da assistência de enfermagem; a organização dos processos e da unidade e os resultados assistenciais são totalmente adequados;

2 - Recursos necessários para prestar assistência - (1) Recursos (estrutura física e/ou equipamentos e/ou materiais e/ou serviços de apoio) não atendem às necessidades assistenciais em termos quantitativos e/ou qualitativos, gerando excessivo consumo do tempo da equipe de enfermagem para sua provisão (aproximadamente 30% da jornada diária de trabalho = 1h 48min de um plantão de 6 horas). (2) Recursos atendem parcialmente às necessidades assistenciais em termos quantitativos e/ou qualitativos, gerando elevado consumo do tempo da equipe de enfermagem para sua provisão (aproximadamente 20% da jornada diária de trabalho = 1h15min de um plantão de 6 horas). (3) Recursos atendem quase que totalmente às necessidades assistenciais em termos quantitativos e/ou qualitativos, gerando moderado consumo do tempo da equipe de enfermagem para sua provisão (aproximadamente 10% da jornada diária de trabalho = 36min de um plantão de 6 horas). (4) Recursos atendem totalmente às necessidades assistenciais em termos quantitativos e qualitativos, gerando baixo consumo do tempo da equipe de enfermagem para sua provisão (aproximadamente 5% da jornada diária de trabalho = 18min de um plantão de 6 horas);

3 - Dimensionamento de pessoal de enfermagem - (1) Dimensionamento de pessoal de enfermagem não compatível com a carga de trabalho (muito abaixo) e, para a(s) ausência(s) prevista(s) ou não prevista(s) do(s) profissional(is), não dispõe de cobertura. (2) Dimensionamento de pessoal de enfermagem não compatível com a carga de trabalho (abaixo) e, para a(s) ausência(s) prevista(s) ou não prevista(s), dispõe de cobertura por meio de Remanejamento(s) e/ou Hora(s) Extra de profissional(is) sem experiência na área. (3) Dimensionamento de pessoal de enfermagem quase que compatível com a carga de trabalho e, para as ausência(s) prevista(s) ou não prevista(s), dispõe de cobertura por meio de Remanejamento(s) e/ou Hora(s) Extra de profissional(is) com experiência na área. (4) Dimensionamento de pessoal de enfermagem compatível com a carga de trabalho e, para as ausência(s) prevista(s) e não prevista(s), dispõe de cobertura com profissionais experientes na área;

4 - Ações educativas e desenvolvimento de pessoal – (1) Não é possível identificar as necessidades de aprendizado e/ou problemas de desempenho da equipe de enfermagem; não realiza ações educativas; não avalia a eficácia das orientações/apoio; não monitora o

desenvolvimento de competências profissionais. (2) É possível identificar as necessidades de aprendizado e/ou problemas de desempenho da equipe de enfermagem; não realiza ações educativas, delega aos membros da equipe o acompanhamento das atividades/procedimentos; não avalia a eficácia das orientações/apoio; não monitora o desenvolvimento de competências profissionais. (3) É possível identificar as necessidades de aprendizado e/ou problemas de desempenho da equipe de enfermagem; realiza ações educativas; não avalia a eficácia das orientações/apoio; não monitora o desenvolvimento de competências profissionais. (4) É possível identificar as necessidades de aprendizado e/ou problemas de desempenho da equipe de enfermagem; realiza ações educativas; avalia a eficácia das orientações/apoio; monitora o desenvolvimento de competências profissionais;

5 - Acompanhamento e transferência do cuidado - (1) Não há acompanhamento da assistência prestada e dos registros realizados pela equipe; a transferência do cuidado (entre plantões e/ou unidades) não é sistematizada e registrada. (2) Há acompanhamento, esporádico, da assistência prestada e dos registros realizados pela equipe; a transferência do cuidado (entre plantões e/ou unidades) é sistematizada e registrada para pacientes com maior demanda de atenção de enfermagem. (3) Há acompanhamento, na maior parte do tempo, da assistência prestada e dos registros realizados pela equipe; a transferência do cuidado (entre plantões e/ou unidades) é sistematizada e registrada para a maioria dos pacientes. (4) Há acompanhamento, contínuo, da assistência prestada e dos registros realizados pela equipe; a transferência do cuidado (entre plantões e/ou unidades) é completamente sistematizada e registrada;

6 - Interação e atuação multidisciplinar - A equipe multidisciplinar não realiza interação (visita/discussão) e registro formal das ações planejadas/realizadas e o plano terapêutico e/ou de alta não é articulado. (2) A equipe multidisciplinar realiza interação (visita/discussão) e registro formal das ações planejadas/realizadas e o plano terapêutico e/ou de alta é articulado para pacientes com maior demanda de atenção. (3) A equipe multidisciplinar realiza interação (visita/discussão) e registro formal das ações planejadas/realizadas e o plano terapêutico e/ou de alta é articulado para a maioria dos pacientes. (4) A equipe multidisciplinar realiza interação (visita/discussão) e registro formal das ações planejadas/realizadas e o plano terapêutico e/ou de alta é articulado para a totalidade dos pacientes;

7 - Atenção ao paciente e/ou familiar - (1) A equipe de enfermagem não estabelece relação acolhedora junto aos pacientes e/ou familiares e não responde ou responde às solicitações/chamadas após 15 minutos; o enfermeiro raramente realiza orientação e/ou acompanhamento do paciente e/ou familiar. (2) A equipe de enfermagem estabelece relação acolhedora para alguns pacientes e/ou familiares e responde às solicitações/chamadas em até

15 minutos; o enfermeiro às vezes realiza orientação e/ou acompanhamento do paciente e/ou familiar. (3) A equipe de enfermagem estabelece relação acolhedora para a grande maioria dos pacientes e/ou familiares e responde às solicitações/chamadas em até 10 minutos; o enfermeiro na maior parte das vezes realiza orientação e/ou acompanhamento do paciente e/ou familiar. (4) A equipe de enfermagem estabelece relação acolhedora para a totalidade dos pacientes e/ou familiares e responde às solicitações/chamadas em até 5 minutos; o enfermeiro sempre realiza orientação e/ou acompanhamento do paciente e/ou familiar; e

8 - Atendimento das necessidades assistenciais – (1) Atende algumas intervenções planejadas; o enfermeiro não realiza as atividades de maior complexidade técnica; possibilidade muito elevada de riscos aos pacientes. (2) Atende algumas intervenções planejadas - prioriza pacientes com maior demanda de atenção de enfermagem; o enfermeiro realiza pequena parte das atividades de maior complexidade técnica; possibilidade elevada de riscos aos pacientes. (3) Atende maior parte das intervenções planejadas; o enfermeiro realiza grande parte das atividades de maior complexidade técnica; possibilidade moderada de riscos aos pacientes. (4) Atende quase que totalmente ou totalmente as intervenções planejadas; o enfermeiro realiza todas as atividades de maior complexidade técnica; possibilidade mínima de riscos aos pacientes (CUCOLO; PERROCA, 2017).

Cada item é seguido de graduação que varia de um a quatro, sendo que, quanto maior a pontuação, melhor o produto do cuidar em enfermagem. Para sua operacionalização, o enfermeiro deve avaliar todos os itens ao final do turno de trabalho (plantão), em um dos quatro níveis considerando a opção que mais se aproxima da realidade vivenciada. Os valores obtidos individualmente, em cada item, são somados e conduzem a uma classificação de acordo com os seguintes intervalos: 8-12 pontos (ruim), 13-21 (regular), 22-30 (bom) e 31-32 (ótimo) (ANEXO B). A escala APROCENF foi preenchida ao final de cada turno de trabalho (plantão), sendo que o enfermeiro deveria assinalar um dos quatro níveis considerando a opção que mais se aproximava da realidade vivenciada. Nesta pesquisa, foi aplicada ao término de cinco plantões em dias diferentes, totalizando 590 avaliações, sendo calculada uma média dos cinco plantões.

A verificação da qualidade do produto do cuidado de enfermagem no contexto do ambiente da prática profissional é um componente importante para a promoção de cuidados eficazes, seguros e centrados no paciente. Diversos fatores influenciam a qualidade do cuidado, e os preditores relacionados ao ambiente da prática profissional desempenham um papel significativo nesse contexto. A verificação e a compreensão desses preditores são essenciais para garantir a entrega de cuidados de qualidade.

Entender a relação entre a qualidade do produto do cuidado de enfermagem e o ambiente de prática profissional é fundamental para melhorar a assistência em saúde e proporcionar cuidados de maior qualidade e segurança aos pacientes.

Os enfermeiros que participaram da pesquisa foram convidados durante o período de trabalho e orientados quanto aos objetivos propostos neste estudo e o modo de preenchimento dos instrumentos utilizados na coleta de dados. Após os participantes aceitarem participar da pesquisa, foi solicitado assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) da fase quantitativa (APÊNDICE B).

#### **4.4.2 Coleta de dados - Etapa qualitativa**

Após a análise estatística dos instrumentos supracitados, foi realizada pela pesquisadora e seus bolsistas a coleta de dados qualitativa, a qual foi realizada nas duas unidades com piores e nas duas unidades com melhores resultados da etapa quantitativa, foram entrevistados nessa etapa 12 enfermeiros que haviam participado da primeira etapa de coleta. Essa estratégia caracteriza-se como um procedimento de conexão, previsto em estudos de métodos mistos explanatórios sequenciais, no qual os resultados da etapa inicial quantitativa orientam a seleção dos participantes da fase qualitativa (CRESWELL, 2021). Entrevistou-se nessa fase três profissionais de cada uma das 4 unidades (duas melhores e duas piores) para distribuição uniforme dos participantes. Foi fornecido o TCLE aos participantes também nessa fase do estudo (APÊNDICE C).

O número de participantes da segunda etapa (qualitativa) foi determinado com base no critério de saturação de dados, ou seja, a inclusão de novos participantes foi interrompida quando as informações coletadas passaram a se repetir, sem agregar novos elementos à compreensão do fenômeno estudado (POLIT; BECK, 2019). A escolha inicial dos participantes seguiu critérios de conveniência, considerando a relevância e disponibilidade dos profissionais para a pesquisa. Essa abordagem visou garantir a profundidade da análise qualitativa e sua complementaridade com os dados quantitativos prévios e de maior peso (CRESWELL, 2021).

A coleta de dados qualitativos foi realizada no período de abril a maio de 2025, por meio de entrevista presencial, individual e semiestruturada. As entrevistas foram realizadas nas próprias dependências do ambiente laboral, em local reservado. A construção do instrumento de coleta (roteiro de entrevista semiestruturado) foi pautada pelos dados da etapa quantitativa.

Essa técnica de pesquisa possibilita o aprofundamento das questões relevantes à temática, ou seja, conhecer a percepção de enfermeiros acerca dos fatores que influenciam na qualidade assistencial, bem como verificar os fatores que interferem na qualidade do cuidado



prestado ao paciente, gerenciamento de dificuldades existentes no cotidiano laboral, assim como sobre o gerenciamento de equipe para a execução de um cuidado qualificado e ainda conhecer as estratégias de gestão do cuidado que poderiam ser desenvolvidas no trabalho, mediante a técnica de entrevista (APÊNDICE D). Estas entrevistas foram gravadas e transcritas e registradas mediante o relato verbal do participante e posteriormente submetidas à análise.

## 4.5 ANÁLISE DOS DADOS

### 4.5.1 Análise de dados - Etapa quantitativa

Os dados quantitativos, gerados a partir da primeira etapa, foram organizados e posteriormente tabulados pela pesquisadora, com auxílio do *Google Sheets*<sup>®</sup>. As variáveis quantitativas foram descritas por média e desvio padrão ou mediana e amplitude interquartílica, conforme distribuição de normalidade aferida pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis categóricas foram apresentadas por frequências absolutas e relativas. Para comparar médias entre hospitais, foram aplicados os testes t-Student para amostras independentes ou ANOVA com o teste de Tukey. Em casos de assimetria, utilizaram-se os testes de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis. Para avaliar as associações entre variáveis contínuas e ordinais, foram aplicados os testes de correlação de Pearson ou Spearman.

Para controle de fatores confundidores, utilizou-se a análise de Regressão Linear Multivariada com critério *Backward*, onde variáveis não significativas foram progressivamente excluídas ( $p < 0,10$ ). O modelo final foi avaliado pelo coeficiente de regressão (b), coeficiente padronizado beta ( $\beta$ ), e o coeficiente de determinação ( $R^2$ ). O critério de entrada das variáveis no modelo foi um valor  $p < 0,05$  na análise bivariada anterior. A adequação do modelo foi verificada pelo gráfico de resíduos (sem tendências) e pela multicolinearidade (correlação entre preditores em um modelo de regressão), utilizando o Fator de Inflação da Variância (VIF), com valores abaixo de 5. A consistência interna de ambas escalas foi avaliada pelo coeficiente alfa de Cronbach. Segundo recomendação técnica, um alfa de Cronbach entre 0,7 e 0,95 indica uma boa consistência interna do instrumento (TERWEE et al, 2007). O nível de significância adotado foi de 5% ( $p \leq 0,05$ ) e as análises foram realizadas no programa *Software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS)<sup>®</sup>, versão 27.0.

### 4.5.2 Análise de dados - Etapa qualitativa

Para o tratamento dos resultados qualitativos, no que tange às entrevistas, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, com a qual foi mantida a atenção às particularidades de cada

relato e à totalidade deles. A análise de conteúdo ocorreu após transcrição dos relatos dos participantes, codificação dos conteúdos e interpretação de seus significados. Foram respeitadas as três fases propostas por Bardin, 2016:

**Fase I:** pré-análise, é a primeira etapa da organização da análise de conteúdo. É por meio dela que o pesquisador começa a organizar o material, nessa fase, ocorre a transcrição das entrevistas. Nessa etapa, deve-se realizar a sistematização das ideias preliminares em quatro etapas, sendo-as: a leitura flutuante; escolha dos documentos; reformulações de objetivos e hipóteses e a formulação de indicadores, as quais darão fim à preparação do material como um todo.

**Fase II:** exploração do material. Fase em que ocorre a escolha das unidades de codificação, adotando-se os procedimentos de codificação, classificação e pré-categorização dos dados, para subsidiar a classificação em blocos que expressem determinadas categorias;

**Fase III:** tratamento dos dados: inferência e interpretação. Nesta fase final, os dados já estão organizados em núcleos de sentidos (subcategorias) e categorias temáticas, mas, para além disso, a análise é aprofundada por meio da interpretação dos sentidos destes temas.

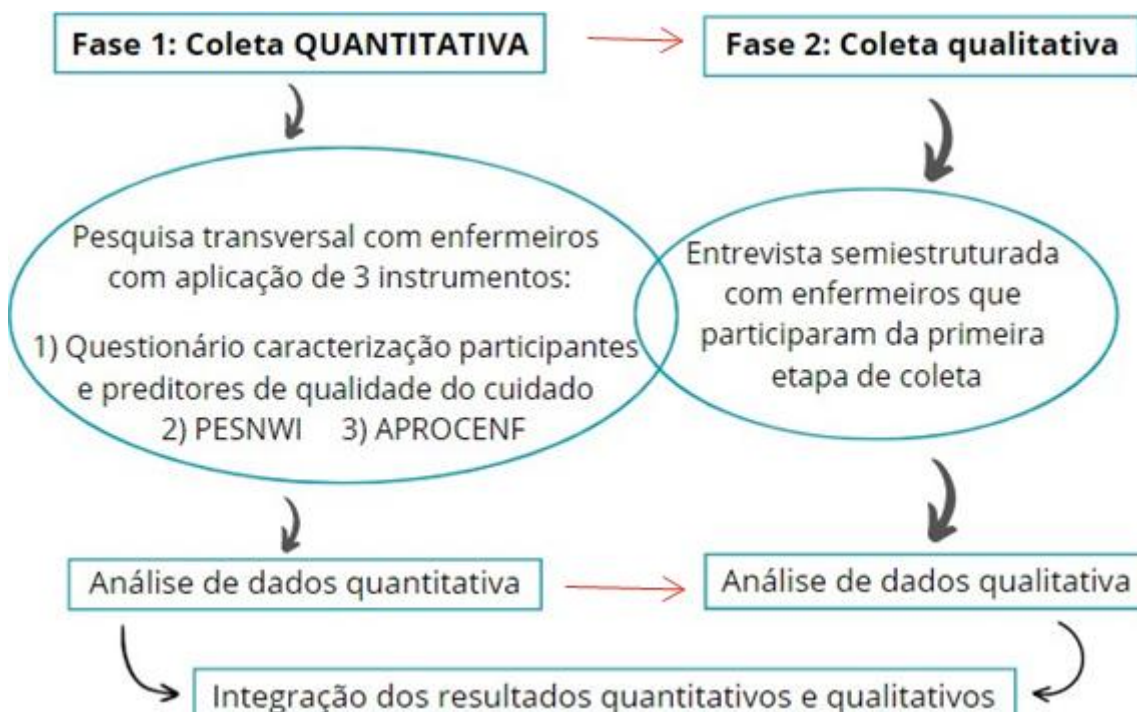
#### 4.5.3 Análise integrada

Foi realizada análise integrativa dos dados quantitativos e qualitativos obtidos na realização do estudo, para tanto foram construídos pilares de integração de dados (JOHNSON; GROVE; CLARKE, 2017).

Uma abordagem para integrar dados em pesquisas de métodos mistos, inclusive na área da enfermagem, é o chamado *Pillar Integration Process* (PIP) - que por si só é uma forma de *joint display* - e corresponde a um processo de quatro etapas: a) identificação dos dados qualitativos e quantitativos mais relevantes, colocando-os nas extremidades de uma tabela/quadro/matriz; b) combinação/correspondência desses dados nas partes opostas da tabela/quadro/matriz, buscando padrões, conexões ou similaridades entre os dados qualitativos e quantitativos, embora o pesquisador possa deixar espaços em branco ou indicar "não encontrado" caso não haja correspondência; c) checagem/verificação, que é uma atividade de avaliação se a correspondência no conjunto de dados é refinada, e um momento oportuno para que o pesquisador reflita sobre seu rol de informações, podendo retomar aspectos ou avançar em algum sentido; e, d) construção de pilares para escrever as inferências geradas da análise mista no centro da tabela/quadro/matriz (JOHNSON; GROVE; CLARKE, 2017).

A Figura 1 ilustra um fluxograma representativo do estudo, abarcando as fases de coleta e análise, explicitando o desenho explanatório sequencial.

**Figura 1** - Fluxograma representativo do estudo explicitando o desenho explanatório sequencial.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

#### 4.6 ASPECTOS ÉTICOS

Os princípios éticos foram respeitados, protegendo-se os direitos dos indivíduos envolvidos, levando-se em consideração as determinações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).

A execução da pesquisa ocorreu após parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer de nº 7.018.796/2024 e CAAE: 80774524.1.0000.5335. A entrada em campo deu-se somente após a aprovação do CEP.

Após a aprovação pelo CEP da SCPA, foi agendada uma reunião com as coordenações do serviço de enfermagem das unidades de internação e unidades de terapia intensiva, a fim de explicar a proposta da pesquisa e como será o procedimento de coleta de dados e entrevistas. Declara-se a isenção de ônus à instituição (APÊNDICE E), bem como de confidencialidade do participante da pesquisa (APÊNDICE F) e utilização e/ou constituição de banco de dados (APÊNDICE G). Além disso, descreve-se o processo de consentimento livre e esclarecido

(APÊNDICE H) e obteve-se a anuência para realização da pesquisa no cenário de estudo (APÊNDICE I).

Os participantes receberam o TCLE, contendo informações quanto ao estudo, seus objetivos e riscos potenciais. A privacidade e o anonimato serão preservados, bem como o sigilo de suas informações. Os participantes permaneceram com uma cópia do TCLE e possuíram total liberdade de adesão, sendo assegurado o direito do pesquisado a suspender sua participação no estudo em qualquer momento, garantindo ainda sua segurança e proteção dos dados. Após assinado e explicado o TCLE os usuários receberam informações do andamento da pesquisa e como seria realizada. Em relação aos riscos, este estudo pode oferecer riscos mínimos, em virtude da possibilidade de desconforto relacionada à reflexão sobre prática profissional no cuidado de pacientes.

Na abordagem qualitativa, as entrevistas foram gravadas por meio de áudio media player em meio digital. Prevendo os procedimentos que assegurassem a confiabilidade, privacidade, proteção e anonimato dos participantes, os mesmos serão identificados pela letra E, que representa a inicial da entrevista, prosseguido do número que representa a sequência dos depoimentos (E1, E2, E3, ...). Após a transcrição da entrevista as gravações em áudio serão arquivadas por cinco anos com finalidade de preservar a identidade dos participantes da pesquisa e após, destruídas. Os participantes foram entrevistados separadamente e em local privado.

## 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme disponibilizado em normas do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRGS, os resultados deste estudo e sua devida discussão são apresentados em formato de dois artigos científicos. Estes, seguem nominados como Artigo “I” e Artigo “II”.

O primeiro manuscrito objetivou avaliar o produto do cuidado de enfermagem e correlacionar variáveis preditoras de qualidade relacionadas às características profissionais e do ambiente de trabalho. Este trabalho contempla os objetivos específicos A, B e D da tese. A proposta é submetê-lo ao pleito à publicação no periódico BMJ Quality & Safety.

Por fim, o segundo artigo teve como objetivo avaliar a influência das características do ambiente da prática de enfermagem na qualidade do produto do cuidado de enfermagem entre hospitais. Sua construção visou alcançar os objetivos A, C, D, E e F da tese. Após a defesa da tese, este será encaminhado para pleito à publicação no periódico Revista da Escola de Enfermagem da USP.

## 6 CONCLUSÃO GERAL

O presente estudo permitiu avaliar de forma abrangente a influência das características do ambiente da prática profissional de enfermagem na qualidade do produto do cuidado, atendendo ao objetivo geral proposto.

No que se refere ao primeiro objetivo específico, que buscou caracterizar os enfermeiros quanto aos aspectos sociodemográficos, de formação e laborais, observou-se um perfil profissional marcado por elevada qualificação acadêmica, tempo de experiência relevante e vínculo institucional estável, com diferenças entre os hospitais analisados. Destaca-se que a elevada proporção de enfermeiros com formação *stricto sensu*, especialmente em um dos hospitais, reflete um contexto institucional específico, fortemente articulado com atividades de ensino e pesquisa, não sendo representativo da realidade predominante nas instituições hospitalares brasileiras.

Quanto à avaliação do produto do cuidado de enfermagem hospitalar, os resultados evidenciaram que, de modo geral, o cuidado foi classificado como satisfatório, com variações entre os hospitais. Observou-se que unidades inseridas em ambientes organizacionais mais estruturados e com maior suporte institucional apresentaram melhores escores no produto do cuidado, especialmente nos domínios relacionados à continuidade assistencial, segurança do paciente e organização do cuidado.

No que concerne à avaliação do ambiente da prática profissional de enfermagem, identificou-se que os hospitais diferiram de forma significativa quanto às características do ambiente de trabalho. Um dos cenários apresentou ambiente classificado como mais favorável, especialmente nos domínios de liderança, suporte gerencial, participação do enfermeiro nas decisões institucionais e fundamentos de enfermagem voltados à qualidade do cuidado, enquanto outro hospital apresentou um ambiente classificado como misto, evidenciando fragilidades relacionadas principalmente à adequação de recursos humanos e materiais.

Ao verificar a correlação entre as variáveis potencialmente preditoras da qualidade do produto do cuidado e as características do ambiente da prática profissional, constatou-se a existência de correlações significativas entre ambientes mais favoráveis e melhores escores do produto do cuidado. Esses achados reforçam que ambientes de prática que oferecem suporte organizacional, liderança efetiva e condições adequadas de trabalho influenciam positivamente na qualidade do cuidado de enfermagem entregue ao paciente.

No tocante ao objetivo de conhecer a percepção dos enfermeiros acerca dos fatores do ambiente de prática que influenciam na qualidade do produto do cuidado, a etapa qualitativa

evidenciou que os profissionais reconhecem o papel central da liderança, da comunicação efetiva, do trabalho em equipe, da autonomia profissional e da disponibilidade de recursos como elementos determinantes para a produção de um cuidado seguro e de qualidade. As falas também revelaram fragilidades relacionadas à sobrecarga de trabalho, à inadequação de dimensionamento de pessoal e às falhas nos processos de transição do cuidado, corroborando os achados quantitativos.

Por fim, ao comparar os hospitais em relação ao ambiente da prática profissional e ao produto do cuidado, ficou evidente que diferenças estruturais, organizacionais e de gestão impactam diretamente tanto a percepção dos enfermeiros quanto os resultados assistenciais. Hospitais com ambiente de prática mais favorável apresentaram melhor desempenho no produto do cuidado, evidenciando a influência direta do contexto organizacional sobre a qualidade da assistência de enfermagem.

Dessa forma, conclui-se que a qualidade do produto do cuidado de enfermagem está intrinsecamente relacionada às características do ambiente da prática profissional, reforçando a necessidade de investimentos institucionais em políticas de valorização profissional, fortalecimento da liderança de enfermagem, melhoria das condições de trabalho e consolidação de ambientes favoráveis à prática, como estratégia essencial para o aprimoramento da qualidade assistencial nos diferentes contextos hospitalares.

## REFERÊNCIAS

- AIKEN, L; PATRICIAN, P. Measuring organizational traits of hospitals: the Revised Nursing Work Index. **Nursing Research**, Filadélfia, v. 49, n. 3, p. 146–153, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1097/00006199-200005000-00006>
- AL-DOSSARY, R. N. The effects of nursing work environment on patient safety in Saudi Arabian hospitals. **Frontiers in Medicine**, Lausana, v. 22, 9:872091, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.3389/fmed.2022.872091>
- ALILYYAN, B.; et al. Nursing experience and leadership skills among staff nurses and intern nursing students in Saudi Arabia: a mixed methods study. **BMC Nursing**, v. 23, n. 87, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01750-1>
- ALSADAAN, N.; et al. Impact of nurse leaders behaviors on nursing staff performance: a systematic review of literature. **Inquiry**, Chicago, v. 60, 469580231178528, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1177/00469580231178528>
- AMBANI Z, KUTNEY-LEE A, LAKE ET. The nursing practice environment and nurse job outcomes: a path analysis of survey data. **Journal of Clinical Nursing**, Oxford , v. 29, n. 13, p. 2602-14, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/jocn.15283>
- AMORIM, T. S.,; et al. Nursing care management for the quality of prenatal care in primary health care. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 26, e20210300, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0300>
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2016. Disponível em: <https://madmunifacs.files.wordpress.com/2016/08/anc3a1lise-de-contec3bado-laurence-bardin.pdf>. Acesso em: 10 set. 2023.
- BARROS A. C. L.; et al. Nursing care management concepts: scoping review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 76, n. 1, e20220020, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0020pt>
- BELLUCCI J. J. A.; MATSUDA, L. M. O enfermeiro no gerenciamento à qualidade em serviço hospitalar de emergência: revisão integrativa da literatura. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 32, n. 4, p. 797-806, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1983-14472011000400022>
- BETSIUO, S.; et al. Nursing errors in intensive care unit and their association with burnout, anxiety, insomnia and working environment: a cross-sectional study. **Hippokratia**, Grécia, v. 26, n.3, p. 110-117, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10266324/>
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. **Diário Oficial União**, Brasília, DF, Seção 1, p. 59, 13 jun. 2013. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/reso466.pdf>. Acesso em: 11 set. 2023.



BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 529**, de 1º de abril de 2013: Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília: 2013.

CAMPBELL, C. M.; et al. Variables associated with missed nursing care in Alabama: a cross-sectional analysis. **Journal of Nursing Management**, v. 28, n. 8, p. 2174–2184, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/jonm.12979>

CAMPONOGARA, S.; et al. Nurses' professional practice environment in Brazilian university hospitals: a multicenter cross-sectional study. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 35, eAPE0333345, 2022. DOI: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2022AO03333459>

CHAFFEE, M. W.; MCNEILL, M. M. A model of nursing as a complex adaptive system. **Nursing Outlook**, v. 55, p. 232-41, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2007.04.003>

CHIAPPINOTTO, S.; COPPE, A.; PALESE, A. What are the reasons for unfinished nursing care as perceived by hospitalized patients? Findings from a qualitative study. **Health Expectations**, Oxford, v. 26, n. 1, p. 256–267, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1111/hex.13652>

CHOTOLLI, M. R.; CUCOLO, D. F.; PERROCA, M. G. Assessment of the product of nursing care in specialized hospitals. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 71, n. 6, p. 2675-81, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0354>

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, D. J. **Projeto de pesquisa métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 5ª ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

CUCOLO, D. F.; PERROCA, M. G. Assessment of the nursing care product (APROCENF): a reliability and construct validity study. **Revista Latino Americana de Enfermagem**, São Paulo, v. 25, p. e2860, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.1495.2860>

CUCOLO, D. F.; PERROCA, M. G. Instrumento para avaliação do produto do cuidar em enfermagem: desenvolvimento e validação de conteúdo. **Revista Latino Americana de Enfermagem**, São Paulo, v. 23, n. 4, p. 642-50, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-1169.0448.2599>

CUCOLO, D. F.; PERROCA, M. G. The qualitative dimension of nursing workload: a measurement proposal. **Revista Latino Americana de Enfermagem**, São Paulo, v. 27, e3238, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.3274.3238>

DANOUDIS, M.; SOH, S. E.; IANSEK, R. Health care experiences of people with parkinson's disease in Australia. **BMC Geriatrics**, v. 23, n. 430, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12877-023-04142-3>

DARAGHMEH, H.; et al. Factors of missed nursing care in intensive care units: palestinian perspective. **Critical Care Nursing Quarterly**, Frederick, v. 47, n. 1, p 62-70, 2024. DOI: 10.1097/CNQ.0000000000000494

DIZ, A. B. M.; LUCAS, P. R. M. B. Hospital patient safety at the emergency department – a systematic review. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 5, p. 1803-1812, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232022275.22742021>

DOHERTY, D. P.; et al. Exploring the charge nurse role transition: a qualitative study of the novice's perspective. **Journal for Nurses in Professional Development**, Hagerstown, v. 38, n. 4, p. 196–205, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1097/NND.0000000000000780>

DONABEDIAN, A. **The Seven Pillars of Quality**. Arch Pathol Lab Med, 114:1115-1119, 1990.

DORIGAN, G.H.; GUIRARDELLO, E. B. Effect of the practice environment of nurses on job outcomes and safety climate. **Revista Latino Americana de Enfermagem**, São Paulo, v. 26, e3056, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2633.3056>

DRENNAN, J.; et al. The association between nurse staffing and quality of care in emergency departments: a systematic review. **International Journal of Nursing Studies**, v. 153, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104706>

DUTRA, C. K. R.; GUIRARDELLO, E. B. Nurse work environment and its impact on reasons for missed care, safety climate, and job satisfaction: A cross-sectional study. **Journal of Advanced Nursing**, Inglaterra, v. 77, n. 5, p. 2398-2406, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/jan.14764>

DUTRA, C. K. R.; SALLES, B. G.; GUIRARDELLO, E. B. Situations and reasons for missed nursing care in medical and surgical clinic units. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 53, e03470, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2017050203470>

EL-GAZAR, H. E., et al. How nursing practice environments limit implicit rationing of care and nurse-assessed adverse events: the role of flow at work. **BMC Nursing**, Londres, v. 23, n. 19, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01644-8>

ELM, E. V.; et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for Reporting Observational Studies. **BMJ : British medical journal**, v. 335, n. 7624, p. 806-808, 2007. DOI: [10.1136/bmj.39335.541782.AD](https://doi.org/10.1136/bmj.39335.541782.AD)

FANEH, T.; ABU-MOGHLI, F.; AHMAD, M. Nursing-sensitive indicators: a concept analysis. **Nursing Management**, Harrow , v. 28, n.3, p.28-33, 2021. DOI: <https://doi.org/10.7748/nm.2021.e1982>

FERREIRA, G. E.; DALL'AGNOL, C. M.; PORTO, A. R. Repercussions of proactivity in the management of care: perceptions of nurses. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, e20160057, 2016. DOI: <https://doi.org/10.5935/1414-8145.20160057>

FERREIRA, M. R. S. C. F.; AMENDOEIRA, J. Estudo de adaptação e validação da Escala de Ambiente de Trabalho da Prática de Enfermagem para a realidade portuguesa. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 48, n. 4, p. 690-697, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000400017>

FERREIRA, V. B.; et al. Transformational leadership in nursing practice: challenges and strategies. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, n. 6, p. e20190364, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0364>

FIORINI, J.; et al. Nursing leadership in clinical practice, its efficacy and repercussion on nursing-sensitive outcomes: A cross-sectional multicentre protocol study. **Journal of Nursing Management**, v. 30, n. 7, p. 3178-3188, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/jonm.13739>

FOWLER, K. R.; ROBBINS, L. K.; LUCERO, A. Nurse manager communication and outcomes for nursing: An integrative review. **Journal of Nursing Management**, v. 29, n. 6, p. 1486-1495, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/jonm.13324>

FU, C. M.; et al. Potential effects of the nursing work environment on the work-family conflict in operating room nurses. **World Journal of Clinical Cases**, Hong Kong, v. 9, n. 26, p. 7738-7749, 2021. DOI: <https://doi.org/10.12998/wjcc.v9.i26.7738>

FURLAN, J. A. S.; GUIRARDELLO, E. B. Practice environment and burnout in intensive care units: is job satisfaction a mediator in this relationship?. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 33, e4713, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.7659.4713>

GASPARINO, R. C.; et al. Leadership, adequate staffing and material resources, and collegial nurse-physician relationships promote better patients, professionals and institutions outcomes. **Journal of Advanced Nursing**, Sydney, v. 77, n. 6, p. 2739-2747, 2021. doi: <https://doi.org/10.1111/jan.14805>

GASPARINO, R. C.; et al. Validation of the Practice Environment Scale among nursing technicians and aides. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 1-6, 2020. DOI: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020AO0243>

GASPARINO, R. C.; GUIRARDELLO, E. B. Validation of the Practice Environment Scale to the brazilian culture. **Journal of Nursing Management**, Oxford, v. 25, n. 5, p. 375-383, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/jonm.12475>

GEA-CABALLERO, V.; et al. Essential elements of professional nursing environments in Primary Care and their influence on the quality of care. **Enfermería Clínica**, Barcelona , v. 28, n. 1, p. 27-35, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2017.07.008>

GEA-CABALLERO, V.; et al. Study of the Strengths and Weaknesses of Nursing Work Environments in Primary Care in Spain. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Suíça, v. 18, n. 2, p. 434, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph18020434>

GRANADOS-PLAZA, M.; et al. Association of Nursing Practice Environment on reported adverse events in private management hospitals: A cross-sectional study. **Journal of Clinical Nursing**, Reino Unido, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/jocn.15806>

GROSJEAN, S.; et al. Co-designing an integrated care network with people living with parkinson's disease: from patients' narratives to trajectory analysis. **Qualitative Health Research**, Newbury, v. 31, n. 14, p. 2585-601, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1177/10497323211042605>

HALL, C.; et al. Evaluating and improving a model of nursing care delivery: a process of partnership. **Collegian**, Subiaco. v. 19, n. 4, p. 203-10, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.colegn.2012.07.003>

HARYANI, A. Predictors of nurse's caring behavior towards patients with critical illness. **Kne Life Sciences**, p. 12-22, 2019. DOI: <https://doi.org/10.18502/kls.v4i13.5221>

HENDY, A.; et al. Nursing professional commitment as a mediator of the relationship between work environment and missed nursing care among nurses: a cross-sectional analysis. **SAGE Open Nurs**, Thousand Oaks, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1177/23779608231226063>

HOEVE, Y. T.; DRENT, G.; KASTERMANS, M. Factors related to motivation, organisational climate and work engagement within the practice environment of nurse practitioners in the Netherlands. **Journal of Clinical Nursing**, Oxford, p. 1–16, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1111/jocn.16914>

HULLEY, S. B.; et al. **Delineando a pesquisa clínica**. 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

HUNG, C. H. Measurement of nursing outcomes from the perspective of the nursing domain. **The Journal of Nursing Research**, Taipei, v. 28, n. 3, e84, 2020. DOI: [10.1097/jnr.0000000000000388](https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000388)

IMAM, A.; et al. Missed nursing care in acute care hospital settings in low-income and middle-income countries: a systematic review. **Wellcome Open Research**, London, v. 21, n. 1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.17431.2>

JESUS, J. A.; BALSANELLI, A. P. Relationship between emergency nurses' professional competencies and the Nursing care product. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, São Paulo, v. 31, e3939, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.6585.3940>

JOHNSON, R. E.; GROVE, A. L.; CLARKE, A. Pillar integration process: a joint display technique to integrate data in mixed methods research. **Journal of Mixed Methods Research**, v. 13, n. 3, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1177/155868981774310>

KASA, AS; GEDAMU, H. Predictors of adult patient satisfaction with nursing care in public hospitals of Amhara region, Northwest Ethiopia. **BMC Health Services Research**, v. 19, n. 52, p. 1-9, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12913-019-3898-3>

KELLY, L. A.; MCHUGH, M. D.; AIKEN, L. H. Nurses outcomes in magnet and nonmagnet hospitals. **Journal of Nursing Administration**, Billerica, v. 41, n. 10, p. 428-33, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1097/NNA.0b013e31822eddbbc>

KIM, H. O.; LEE, I.; LEE, B. S. Nursing leaders' perceptions of the state of nursing leadership and the need for nursing leadership education reform: A qualitative content analysis from South Korea. **Journal of Nursing Management**, Oxford, v. 30, n. 7, p. 2216-2226, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/jonm.13596>

KOERICH1, C.; ERDMANN, A. L.; LANZONI, G. M. M. Professional interaction in management of the triad: Permanent Education in Health, patient safety and quality. **Revista Latino Americana de Enfermagem**, São Paulo, v. 28, e3379, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.4154.3379>

KUTNEY-LEE, A.; et al. Changes in patient and nurse outcomes associated with magnet hospital recognition. **Medical Care**, Filadélfia, v. 53, n. 6, p. 550-7, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1097/MLR.0000000000000355>

KRAAIJ, J. A.; et al. Differentiated nursing practice as a catalyst for transformations in nursing: A multiphase qualitative interview study. **Journal of Advanced Nursing**, Sydney, v. 78, n. 1, p. 165-175, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/jan.15001>

LAKE, E. T. Development of the practice environment scale of the Nursing Work Index. **Research in Nursing & Health**, New York, v. 25, n. 3, p.176-88, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1002/nur.10032>

LAPIEDRA, R. O.; BARRADO-NARVIÓN, M. J.; BERNUÉS-OLIVÁN, J. Acquisition of competencies of nurses: improving the performance of the healthcare system. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 20, n. 5, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph20054510>

LOPES, R. P.; et al. Professional practice environment and nursing work stress in neonatal units. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 55, e20200539, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2020-0539>

LUCAS, P.; et al. Validation of the Psychometric Properties of the Practice Environment Scale of Nursing Work Index in Primary Health Care in Portugal. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 12, 6422, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18126422>

MAGALHÃES, A. P. N.; et al. Working conditions in nursing in the face of Covid-19 from the perspective of precariousness. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 76, n.1, e20220679, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0679>

MARCELINO, C. F.; et al. Validation of the Nursing Work Index - revised among nursing aides and technicians. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 27, n. 4, p. 305-10, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201400052>

MARCOTTE, L. M.; LIAO, J. M. What we talk about when we talk about care management. **The American Journal of Managed Care**, Old Bridge, v. 26, n. 6, p. 245-247, 2020. DOI: <https://doi.org/10.37765/ajmc.2020.43486>

MARTINS, M. **Qualidade do cuidado de saúde**. In: Souza P, Mendes W, organizadores. *Segurança do Paciente: conhecendo os riscos nas organizações de saúde*. Rio de Janeiro: EAD ENSP; 2019. p. 27-40. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/tzvzr/pdf/sousa-9788575416419-04.pdf>. Acesso em: 07 dez. 2024.

MCCLURE, M. L.; POULIN, M. A.; SOVIE, M. D. Magnet hospitals. Attraction and retention of professional nurses. **Kansas City**: American Nurses Association; 1983.

MCHUGH, M. D.; STIMPFEL A. W. Nurse Reported Quality of Care: A Measure of Hospital Quality. **Research in Nursing & Health**, , v. 35, n. 6, p. 566–575, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1002/nur.21503>

MENESES, A. S; CUNHA, I. C. K. O. Content validation in concepts of management and managerial practices in nursing. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 75, n. 4, e20210600, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0600>

MENEZES, H. G. G.; et al. Relationship between leadership coaching and nurses' resilience in hospital environments. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 56, e20220265, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0265en>

MIHDAWI, M. et al. The Influence of Nursing Work Environment on Patient Safety. **Workplace Health & Safety**, United States, v. 68, n. 8, p. 384-390, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1177/2165079920901533>

MÖLLER, G.; et al. Nursing practice environment in intensive care unit and professional burnout. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 55, e20200409, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2020-00409>

MONDINI, C. C. S. D.; et al. Authentic leadership among nursing professionals: knowledge and profile. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, n. 4, e20180888, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0888>

MORAES, M. C. S.; et al. Nursing coaching leadership and its influence on job satisfaction and patient safety. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 55, e03779, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020042103779>

NWANOSIKE, E.; et al. Nurse Staffing Configurations and Sickness Absence in English ICUs: A Longitudinal Observational Study. **International Journal of Nursing Studies Advances**, 100451, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2025.100451>

OCKERBY, C.; et al. Exploring the relationship between compassion, the practice environment, and quality of care as perceived by paediatric nurses. **Journal of Pediatric Nursing**, S0882-5963(23)00309-3, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.10.032>

OFEI, A. M. A.; PAARIMA, Y.; BARNES, T. Exploring the management competencies of nurse managers in the Greater Accra Region, Ghana. **International Journal of Africa Nursing Sciences**, v. 13, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100248>

O'HARA M. A.; et al. Assessment of millennial nurses' job satisfaction and professional practice environment. **Journal of Nursing Administration**, Billerica, v. 49, n. 9, p. 411-7, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000777>

OLIVEIRA, C.; et al. Leadership in the perspective of Family Health Strategy nurses. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 41, n. 3, e20190106, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2020.20190106>

OLIVEIRA, J. L. C. Integração de dados em pesquisas de métodos mistos: desafio e oportunidade para a enfermagem. **Texto & Contexto Enfermagem**, Santa Catarina, 29, e20200203, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2020-0002-0003>

OLIVEIRA, R. M. et al. Strategies for promoting patient safety: from the identification of the risks to the evidence-based practices. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 122-129, 2014. DOI: <https://doi.org/10.5935/1414-8145.20140018>

PACTO GLOBAL. **ODS e agenda 2030**. Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.pactoglobal.org.br/ods-e-agenda-2030/>. Acesso em: 18 abr. 2024.

PAGUIO, J. T.; YU, D. S. F.; SU, J. J. Systematic review of interventions to improve nurses' work environments. **Journal of Advanced Nursing**, v. 76, p. 2471-93, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/jan.14462>

PALHANO, R. A. R.; et al. Competências profissionais para o gerenciamento de recursos humanos na equipe de enfermagem. **Brazilian Journal of health Review**. v. 3, n. 6, p. 17315–17323, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv3n6-152>

PAPATHANASIOU, I.; et al. Missed nursing care; prioritizing the patient's needs: an umbrella review. **Healthcare**, Basel, v. 12, n. 2, p. 1-14. 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/healthcare12020224>

PARREIRA, P.; et al. Work methods for nursing care delivery. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 18, n. 4, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph18042088>

PERRUCHOUD, E.; et al. The impact of nursing staffs' working conditions on the quality of care received by older adults in long-term residential care facilities: a systematic review of interventional and observational studies. **Geriatrics**, Basel, v. 7, n. 1, p. 6, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/geriatrics7010006>

POLIT, D. F.; BECK, C. T. **Fundamentos de pesquisa em enfermagem**. 9ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.

PORTUGAL. Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. **Despacho n.º 9390/2021**. Aprova o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2021-2026 (PNSD 2021-2026). Diário da República, 2a série, n. 187. Lisboa, PT, 2021. Available from: <https://www.arsnorte.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2021/09/Plano-Nacional-para-a-Seguranca-dos-Doentes-2021-2026.pdf>. Acesso em: 10 an 2023.

RAMIRES, F. J. A. Implementation of Healthcare Quality Improvement Programs. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 115, n.1, p. 100-101, 2020. DOI: <https://doi.org/10.36660/abc.20200679>

REIS, C. T.; MARTINS, M.; LAGUARDIA, J. A segurança do paciente como dimensão da qualidade do cuidado de saúde: um olhar sobre a literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 7, p. 2029-36, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000700018>

READ, J.; et al. Transitions and challenges for people with parkinson's and their family members: a qualitative study. **PLoS ONE**, San Francisco, v. 17, n. 7, e0268588, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268588>

RIBOLDI, C. A.; et al. Environment of the professional Nursing practice in latin american countries: a scoping review. **Online Brazilian Journal of Nursing**, Rio de Janeiro, v. 20, e20216473, 2021. DOI: <https://doi.org/10.17665/1676-4285.20216473>

RIEGEL, F.; et al. Florence Nightingale's theory and her contributions to holistic critical thinking in nursing. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 74, n. 2, e20200139, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0139>

RIMAN, K. A., et al. Work environment and operational failures associated with nurse outcomes, patient safety, and patient satisfaction. **Nursing Research**, Nova York, v. 72, n. 1, p.20-29, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000626>

ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. **Epidemiologia e saúde**. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2017.

SABEI, S. D. A.; et al. Nursing Work Environment, Turnover Intention, Job Burnout, and Quality of Care: The Moderating Role of Job Satisfaction. **Jurnal of Nursing Scholarship**, Estados Unidos, v. 52, n. 1, p. 95-104, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/jnu.12528>

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. **Metodologia de pesquisa**. 5ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

SANTA CASA DE PORTO ALEGRE. **Sobre a Santa Casa**. Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://www.santacasa.org.br/pagina/sobre-a-santa-casa>. Acesso em: 10 out. 2025.

SANTOS, M. N.; SOARES, O. M. **Urgência e emergência na prática da enfermagem** Porto Alegre: Ed. Moriá, 2014.

SERGIO, M. F. S. B. B.; et al. Clinical supervision: a contribution to improving quality indicators in nursing care. **Cogitare Enfermagem**, v. 28, e92940, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/ce.v28i0.89400>

SILLERO-SILLERO, A.; ZABALEGUI, A. Analysis of the work environment and intention of perioperative nurses to quit work. **Revista Latino Americana de Enfermagem**, São Paulo, v. 28, e3256, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.3239.3256>

SILVA, G. T. R.; et al. Management and leadership in the nurses' perception: A walk in the light of professional bureaucracy. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 26, e20210070, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0070>

SIMONETTI, M.; AIKEN, L. H.; LAKE, E. T. Association between the nurse work environment and patient experience in Chilean hospitals: A multi-hospital cross-sectional study. **Journal of Nursing Scholarship**, v. 55, n. 6, p. 248-1257, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1111/jnu.12898>

SKELA-SAVIC, B.; et al. How nurses' job characteristics affect their self-assessed work environment in hospitals— Slovenian use of the practice environment scale of the nursing work index. **BMC Nursing**, v. 22, n. 100, p.1-12, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01261-5>

SMELTZER, S. C. et al. (Ed.) **Brunner & Suddarth tratado de enfermagem medicocirúrgica**. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

SOMMER, D.; WILHELM, S.; WAHL, F. Nurses' workplace perceptions in southern germany-job satisfaction and self-intended retention towards nursing. **Healthcare**, Basel, v. 12, n. 2, p. 172, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/healthcare12020172>

STEMMER, R.; et al. A systematic review: Unfinished nursing care and the impact on the nurse outcomes of job satisfaction, burnout, intention-to-leave and turnover. **Journal of Advanced Nursing**, v. 78, n. 8, p. 2290-2303, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/jan.15286>

STUCKY, C. H.; et al. Periop 101: improving perioperative nursing knowledge and competence in labor and delivery nurses through an evidence-based education and training



program. **Military Medicine**, Washington, v. 189, n. 1, p. 24-30, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1093/milmed/usad287>

STUCKY, C. H.; WYMER, J. A.; HOUSE, S. Nurse leaders: transforming interprofessional relationships to bridge healthcare quality and safety. **Nurse Leader**, v. 20, n. 4, p. 375-380, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2021.12.003>

TERWEE, C. B.; et al. Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. **Journal of Clinical Epidemiology**, v. 60, n. 1, p. 34-42, 2007. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2006.03.012>

ULRICH, B.; et al. Critical care nurse work environments 2018: findings and implications. **Critical Care Nurse**, Bridgewater, v. 39, n. 2, p. 67-84, 2019. DOI: <https://doi.org/10.4037/ccn2019605>

WARSHAWSKY, N. E.; HAVENS, D. S. Global use of the practice environment Scale of the Nursing Work Index. **Nursing Research**. New York, v. 60, n. 1, p.17-31, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1097/NNR.0b013e3181ffa79c>

WHITE, E. M.; et al. Nursing home work environment, care quality, registered nurse burnout and job dissatisfaction. **Geriatric Nursing**, Nova York, v. 41, n. 2, p. 158-164, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2019.08.007>

WILLIAMS, L.; et al. Healthy work environment standards in tele-critical care nursing. **Advanced Critical Care**, Estados Unidos, v. 34, n. 4, p. 350-358, 2023. DOI: <https://doi.org/10.4037/aacnacc2023407>

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global patient safety action plan 2021-2030. **Towards zero patient harm in health care. First draft**, 2020. Disponível em: [https://www.who.int/docs/default-source/patient-safety/1st-draft-global-patient-safety-action-plan-august-2020.pdf?sfvrsn=9b1552d2\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/patient-safety/1st-draft-global-patient-safety-action-plan-august-2020.pdf?sfvrsn=9b1552d2_4). Acesso em: 04 dez. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global Priorities for patient safety research**, 2009. Disponível em: [https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44205/9789241598620\\_eng.pdf?sequence=1](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44205/9789241598620_eng.pdf?sequence=1). Acesso em: 04 mar. 2024.

YAHYAEI A. A.; et al. Nurses' intention to stay in the work environment in acute healthcare: a systematic review. **Journal of Research in Nursing**, Londres, v. 27, n. 4, p. 374-97, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1177/17449871221080731>

YANARICO, D. M. I.; et al. Classification and evaluation of the environment of the professional nursing practice in a teaching hospital. **Revista Latino Americana de Enfermagem**, São Paulo, v. 28, e3376, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.4339.3376>

ZAVALA B. I. M.; ZAMORA-MACORRA, M.; ALCÁNTARA, S. M. Working conditions and the components of burnout among nursing staff in a public hospital in Mexico city. **Journal of Nursing Research**, Taipei, v. 30, n. 4, e219, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000495>

ZHAO, Y.; et al. Associations between work environment and implicit rationing of nursing care: A systematic review. **Journal of Nursing Management**, v. 28, n. 8, p. 1841–1850, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/jonm.12895>

## ANEXO A - ESCALA AMBIENTE DE TRABALHO DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM - PES-NWI

### Practice Environment Scale of Nursing Work Index – Versão Brasileira

Por favor, indique para cada item nesta seção, até que ponto você concorda que ele está presente em seu trabalho atual. Indique o quanto você concorda, fazendo um círculo em volta do número apropriado.

|           |                                                                                                                                  | <b>Discordo<br/>totalmente</b> | <b>Discordo<br/>parcialmente</b> | <b>Concordo<br/>parcialmente</b> | <b>Concordo<br/>totalmente</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>  | Serviços de apoio adequados que me permitem dedicar tempo aos pacientes.                                                         | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>2</b>  | Equipe médica e de enfermagem possuem boas relações de trabalho.                                                                 | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>3</b>  | Uma equipe de gerente/coordenador/supervisor, da unidade, que dá suporte à enfermagem.                                           | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>4</b>  | Desenvolvimento ativo da equipe ou programas de educação continuada para a enfermagem.                                           | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>5</b>  | Oportunidade de desenvolvimento na carreira profissional.                                                                        | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>6</b>  | Os gerentes / coordenadores / supervisores da unidade, utilizam os erros como oportunidades de aprendizagem e não como críticas. | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>7</b>  | Tempo e oportunidade suficientes para discutir com outros enfermeiros os problemas relacionados aos cuidados do paciente.        | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>8</b>  | Equipe de enfermagem em número suficiente para proporcionar aos pacientes um cuidado de qualidade.                               | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>9</b>  | O responsável técnico /diretor / gerente de enfermagem é um bom administrador e líder.                                           | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>10</b> | Equipe de enfermagem suficiente para realizar o trabalho.                                                                        | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>11</b> | Reconhecimento e elogio por um trabalho bem feito.                                                                               | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>12</b> | A enfermagem e médicos trabalham bem em equipe.                                                                                  | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |

|           |                                                                                                                                                            | <b>Discordo<br/>totalmente</b> | <b>Discordo<br/>parcialmente</b> | <b>Concordo<br/>parcialmente</b> | <b>Concordo<br/>totalmente</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>13</b> | Oportunidades de aperfeiçoamento.                                                                                                                          | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>14</b> | Uma filosofia de enfermagem clara que permeia o ambiente de cuidado ao paciente.                                                                           | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>15</b> | Trabalho com enfermeiros clinicamente competentes.                                                                                                         | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>16</b> | O gerente / coordenador / supervisor de enfermagem, da unidade, dá suporte à sua equipe, em suas decisões, mesmo que conflitem com as do médico.           | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>17</b> | A administração da instituição ouve e responde às preocupações dos trabalhadores.                                                                          | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>18</b> | Programa ativo de garantia da qualidade.                                                                                                                   | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>19</b> | Os enfermeiros são envolvidos na direção interna do hospital (como por exemplo, nos comitês de normas e de práticas clínicas).                             | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>20</b> | Colaboração (prática conjunta) entre as equipes médicas e de enfermagem.                                                                                   | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>21</b> | Programa de acompanhamento / tutoria dos profissionais de enfermagem recém contratados.                                                                    | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>22</b> | O gerente / coordenador / supervisor de enfermagem, da unidade, consulta a equipe sobre os procedimentos e problemas do dia a dia.                         | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>23</b> | Planos de cuidado de enfermagem escritos e atualizados para todos os pacientes.                                                                            | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |
| <b>24</b> | A designação de pacientes promove a continuidade do cuidado (isto é: um mesmo profissional de enfermagem cuida dos mesmos pacientes em dias consecutivos). | 1                              | 2                                | 3                                | 4                              |

## ANEXO B - AVALIAÇÃO DO PRODUTO DO CUIDAR EM ENFERMAGEM -

### APROCENF

Setor: \_\_\_\_\_

Turno: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

#### 1. PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

- 1- É realizado planejamento da assistência de enfermagem de forma verbal para a totalidade dos pacientes a partir de avaliação indireta (mediante coleta de informações junto à equipe).
- 2- É realizado planejamento da assistência de enfermagem de forma verbal para a maioria dos pacientes a partir de avaliação indireta e realizado planejamento sistematizado (registro formal) por meio de avaliação direta (visita clínica) dos pacientes com maior demanda de atenção de enfermagem.
- 3- É realizado planejamento da assistência de enfermagem de forma sistematizada (registro formal) para a maioria dos pacientes a partir de avaliação direta (visita clínica).
- 4- É realizado planejamento da assistência de enfermagem de forma sistematizada (registro formal) para a totalidade dos pacientes a partir de avaliação direta (visita clínica) com complementação de informações junto à equipe (avaliação indireta).

#### 2. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA

- 1- Recursos (estrutura física e/ou equipamentos e/ou materiais e/ou serviços de apoio) não atendem às necessidades assistenciais em termos quantitativos e/ou qualitativos, gerando excessivo consumo do tempo da equipe de enfermagem para sua provisão (aproximadamente 30% da jornada diária de trabalho = 1h 48min de um plantão de 6 horas).
- 2- Recursos atendem parcialmente às necessidades assistenciais em termos quantitativos e/ou qualitativos, gerando elevado consumo do tempo da equipe de enfermagem para sua provisão (aproximadamente 20% da jornada diária de trabalho = 1h15min de um plantão de 6 horas).
- 3- Recursos atendem quase que totalmente às necessidades assistenciais em termos quantitativos e/ou qualitativos, gerando moderado consumo do tempo da equipe de enfermagem para sua provisão (aproximadamente 10% da jornada diária de trabalho = 36min de um plantão de 6 horas).
- 4- Recursos atendem totalmente às necessidades assistenciais em termos quantitativos e qualitativos, gerando baixo consumo do tempo da equipe de enfermagem para sua provisão (aproximadamente 5% da jornada diária de trabalho = 18min de um plantão de 6 horas).

#### 3. DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM

- 1- Dimensionamento de pessoal de enfermagem não compatível com a carga de trabalho (muito abaixo) e, para a(s) ausência(s) prevista(s) ou não prevista(s) do(s) profissional(is), não dispõe de cobertura.
- 2- Dimensionamento de pessoal de enfermagem não compatível com a carga de trabalho (abaixo) e, para a(s) ausência(s) prevista(s) ou não prevista(s), dispõe de cobertura por meio de Remanejamento(s) e/ou Hora(s) Extra de profissional(is) sem experiência na área.
- 3- Dimensionamento de pessoal de enfermagem quase que compatível com a carga de trabalho e, para as ausência(s) prevista(s) ou não prevista(s), dispõe de cobertura por meio de Remanejamento(s) e/ou Hora(s) Extra de profissional(is) com experiência na área.
- 4- Dimensionamento de pessoal de enfermagem compatível com a carga de trabalho e, para a(s) ausência(s) prevista(s) e não prevista(s), dispõe de cobertura com profissionais experientes na área.

#### 4. AÇÕES EDUCATIVAS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

- 1- Não é possível identificar as necessidades de aprendizado e/ou problemas de desempenho da equipe de enfermagem; não realiza ações educativas; não avalia a eficácia das orientações/apoio; não monitora o desenvolvimento de competências profissionais.
- 2- É possível identificar as necessidades de aprendizado e/ou problemas de desempenho da equipe de enfermagem; não realiza ações educativas, delega aos membros da equipe o acompanhamento das atividades/procedimentos; não avalia a eficácia das orientações/apoio; não monitora o desenvolvimento de competências profissionais.
- 3- É possível identificar as necessidades de aprendizado e/ou problemas de desempenho da equipe de enfermagem; realiza ações educativas; não avalia a eficácia das orientações/apoio; não monitora o desenvolvimento de competências profissionais.

4- É possível identificar as necessidades de aprendizado e/ou problemas de desempenho da equipe de enfermagem; realiza ações educativas; avalia a eficácia das orientações/apoio; monitora o desenvolvimento de competências profissionais.

#### **5. ACOMPANHAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO CUIDADO**

1- Não há acompanhamento da assistência prestada e dos registros realizados pela equipe; a transferência do cuidado (entre plantões e/ou unidades) não é sistematizada e registrada.

2- Há acompanhamento, esporádico, da assistência prestada e dos registros realizados pela equipe; a transferência do cuidado (entre plantões e/ou unidades) é sistematizada e registrada para pacientes com maior demanda de atenção de enfermagem.

3- Há acompanhamento, na maior parte do tempo, da assistência prestada e dos registros realizados pela equipe; a transferência do cuidado (entre plantões e/ou unidades) é sistematizada e registrada para a maioria dos pacientes.

4- Há acompanhamento, contínuo, da assistência prestada e dos registros realizados pela equipe; a transferência do cuidado (entre plantões e/ou unidades) é completamente sistematizada e registrada.

#### **6. INTERAÇÃO E ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR**

1-A equipe multidisciplinar não realiza interação (visita/discussão) e registro formal das ações planejadas/realizadas e o plano terapêutico e/ou de alta não é articulado.

2-A equipe multidisciplinar realiza interação (visita/discussão) e registro formal das ações planejadas/realizadas e o plano terapêutico e/ou de alta é articulado para pacientes com maior demanda de atenção.

3-A equipe multidisciplinar realiza interação (visita/discussão) e registro formal das ações planejadas/realizadas e o plano terapêutico e/ou de alta é articulado para a maioria dos pacientes.

4-A equipe multidisciplinar realiza interação (visita/discussão) e registro formal das ações planejadas/realizadas e o plano terapêutico e/ou de alta é articulado para a totalidade dos pacientes.

#### **7. ATENÇÃO AO PACIENTE E/OU FAMILIAR**

1-A equipe de enfermagem não estabelece relação acolhedora junto aos pacientes e/ou familiares e não responde ou responde às solicitações/chamadas após 15 minutos; o enfermeiro raramente realiza orientação e/ou acompanhamento do paciente e/ou familiar.

2-A equipe de enfermagem estabelece relação acolhedora para alguns pacientes e/ou familiares e responde às solicitações/chamadas em até 15 minutos; o enfermeiro às vezes realiza orientação e/ou acompanhamento do paciente e/ou familiar.

3-A equipe de enfermagem estabelece relação acolhedora para a grande maioria dos pacientes e/ou familiares e responde às solicitações/chamadas em até 10 minutos; o enfermeiro na maior parte das vezes realiza orientação e/ou acompanhamento do paciente e/ou familiar.

4-A equipe de enfermagem estabelece relação acolhedora para a totalidade dos pacientes e/ou familiares e responde às solicitações/chamadas em até 5 minutos; o enfermeiro sempre realiza orientação e/ou acompanhamento do paciente e/ou familiar.

#### **8. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS**

1- Atende algumas intervenções planejadas; o enfermeiro não realiza as atividades de maior complexidade técnica; possibilidade muito elevada de riscos aos pacientes.

2- Atende algumas intervenções planejadas - prioriza pacientes com maior demanda de atenção de enfermagem; o enfermeiro realiza pequena parte das atividades de maior complexidade técnica; possibilidade elevada de riscos aos pacientes.

3- Atende maior parte das intervenções planejadas; o enfermeiro realiza grande parte das atividades de maior complexidade técnica; possibilidade moderada de riscos aos pacientes.

4- Atende quase que totalmente ou totalmente as intervenções planejadas; o enfermeiro realiza todas as atividades de maior complexidade técnica; possibilidade mínima de riscos aos pacientes.

**ESCORE TOTAL = \_\_\_\_\_**

**AVALIAÇÃO DO PRODUTO DO CUIDAR EM ENFERMAGEM AO FINAL DO TURNO DE TRABALHO**

**RUIM** - 8 a 12 pontos

**REGULAR** - 13 a 20 pontos

**BOM** - 21 a 28 pontos

**ÓTIMO** - 29 a 32 pontos

## ANEXO C - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE PORTO  
ALEGRE - ISCMPA



### PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

#### DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

**Título da Pesquisa:** AMBIENTE DA PRÁTICA PROFISSIONAL E PREDITORES DA QUALIDADE DO PRODUTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM

**Pesquisador:** NICOLE HERTZOG RODRIGUES

**Área Temática:**

**Versão:** 3

**CAAE:** 80774524.1.0000.5335

**Instituição Proponente:** Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - ISCMPA

**Patrocinador Principal:** Financiamento Próprio

#### DADOS DO PARECER

**Número do Parecer:** 7.018.796

#### Apresentação do Projeto:

Os ambientes de trabalho da enfermagem são constituídos por características que favorecem ou dificultam a prestação de cuidados, e a governança dos enfermeiros na gestão assistencial e dos recursos envolvidos. Características como a relação entre médico e enfermeiro, a liderança de enfermagem e adequação recursos humanos são elementos constituintes do ambiente de prática de enfermagem (SIMONETTI; AIKEN; LAKE, 2023). Portanto, ambientes de trabalho positivos levam tanto a melhores resultados clínico-assistenciais, como também organizacionais (GEA-CABALLERO et al., 2021; SIMONETTI; AIKEN; LAKE, 2023). O ambiente de trabalho da enfermagem influencia na prática assistencial e na qualidade do cuidado, podendo ser impactado pelo conhecimento dos profissionais, pelos recursos disponíveis e pelo contexto cultural da instituição/serviço em que os cuidados de enfermagem são prestados (FU et al., 2021; GRANADOS-PLAZA et al., 2021; SKELA-SAVIC et al., 2023). Neste aspecto, ao avaliar positivamente o ambiente de prática profissional, trabalhadores de enfermagem tendem a referir menos razões para omitir cuidados, além de avaliar mais positivamente o clima de segurança do paciente e também a sua própria satisfação com o trabalho (DUTRA; GUIRARDELLO, 2021). Evidências recentes apontam uma relação diretamente proporcional no reconhecimento de fundamentos organizacionais que apolam a qualidade dos cuidados de enfermagem por enfermeiros com a melhor avaliação destes mesmos sujeitos sobre a entrega do cuidado produzido (OCKERBY et al., 2023). Isso é

**Endereço:** Avenida Osvaldo Aranha, nº 80, sala 17, Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar.

**Bairro:** Centro Histórico

**CEP:** 90.035-190

**UF:** RS

**Município:** PORTO ALEGRE

**Telefone:** (51)3214-8571

**Fax:** (51)3214-8571

**E-mail:** cep@santacasa.tche.br

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE PORTO  
ALEGRE - ISCMPA



Continuação do Parecer: 7.010.796

relevante porque, há mais de uma década, pesquisadores afirmaram que quando enfermeiros referem (ou seja, opinam) que a qualidade do cuidado produzido na sua unidade é boa, a chance disso ser confirmado por outras medidas, como Indicadores assistenciais, é alta (MCHUGH; STIMPFEL, 2012). Determinados preditores do ambiente laboral, como por exemplo, carga de trabalho, proporção paciente/enfermeiro, nível de capacitação do pessoal de enfermagem, Índice de rotatividade de enfermeiros, além das chamadas soft skills, como

comunicação, trabalho em equipe e liderança, influenciam no produto do cuidado de enfermagem (GRANADOS-PLAZA et al., 2021; JESUS; BALSANELLI, 2023). O produto do cuidado de enfermagem pode ser compreendido como o resultado da interação entre fatores estruturais (capital humano e serviços de suporte) e métodos de organização do trabalho (planejamento assistencial, atenção ao paciente/família e interação multidisciplinar) que intervêm no processo de cuidar. Quanto mais favorável for o alinhamento entre esses fatores e métodos, melhor será o produto do cuidado (CUCOLO; FERROCA, 2017). É inegável que o produto do cuidado não é dissociado do ambiente de trabalho em que ele está inserido, uma vez que o ambiente de trabalho não apenas molda as interações entre os profissionais de saúde, mas também influencia diretamente a capacidade de fornecer atendimento empático, coordenado e de alta qualidade. Assim, para alcançar um cuidado verdadeiramente excelente, é essencial cultivar ambientes de trabalho que promovam a colaboração, ofereçam recursos adequados e apoiem o bem-estar dos profissionais de saúde, inclusive - e talvez principalmente - os trabalhadores de enfermagem (GEA-CABALLERO et al., 2021; SIMONETTI; AIKEN; LAKE, 2023). A consciência dos fatores que influenciam o ambiente de prática dos profissionais de

enfermagem pode ser usada como uma ferramenta para avaliar e melhorar o ambiente de trabalho atual, podendo contribuir para a prática e qualidade assistencial (HOEVE; DRENT; KASTERMANS, 2023). Entretanto, pesquisas capazes de identificar com profundidade elementos do ambiente da prática de enfermagem que repercutem ou expliquem a qualidade do produto do cuidado não são tão comuns como aquelas que simplesmente diagnosticam o ambiente de trabalho, ao menos na América-Latina (RIBOLDI et al., 2021). As lideranças de enfermagem

desempenham um papel importante no estabelecimento de melhores ambientes de trabalho para os enfermeiros, propondo e estabelecendo melhorias nos processos de cuidado e de gestão (PAGUIO; YU; SU, 2020; GEA-CABALLERO et al., 2021). Concorda com essa alusão estudo transversal realizado com 1.773 enfermeiros de em cinco hospitais brasileiros que avaliou

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº 80, sala 17, Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar.  
Bairro: Centro Histórico CEP: 90.035-190  
UF: RS Município: PORTO ALEGRE  
Telefone: (51)3214-8571 Fax: (51)3214-8571 E-mail: cep@santacasa.tche.br



IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE PORTO  
ALEGRE - ISCMPA



Continuação do Parecer: 7.018.796

estratégias a serem priorizadas para o alcance de melhores resultados na prática de enfermagem. Evidenciou-se que as características do ambiente de prática profissional que mais contribuem para alcançar melhores resultados incluem a capacidade do enfermeiro gestor, a liderança e o apoio organizacional aos enfermeiros, a adequação de pessoal e recursos e as relações profissionais entre enfermeiro e médico (GASPARINO et al., 2021). Todavia, são poucos os estudos que comparam o impacto potencial das diversas características organizacionais do ambiente de trabalho hospitalar no serviço de enfermagem (FU et al., 2021). Já em estudo realizado com o objetivo investigar o impacto do ambiente de trabalho da enfermagem na segurança dos pacientes em hospitais da Arábia Saudita, evidenciou-se que os fatores do ambiente de trabalho da enfermagem, especialmente participação, gestão e liderança, cuidados de enfermagem, relações interdisciplinares e a disponibilidade de recursos, são fatores que interferem na qualidade assistencial e segurança dos pacientes (AL-DOS-SARY, 2022). A qualidade do cuidado de enfermagem é uma preocupação central na dinâmica dos serviços de saúde e diversos fatores podem influenciá-la. Trata-se de um componente fundamental na promoção do bem-estar dos pacientes e no alcance de resultados positivos às organizações (SIMONETTI; AIKEN; LAKE, 2023). Contudo, conforme exposto, essa qualidade não é um resultado isolado, mas sim uma interseção complexa de fatores multifacetados. Nesse contexto, a atenção aos preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem torna-se imperativa porque isso pode explicar melhor como elementos relacionais das equipes, processuais do trabalho e os recursos disponíveis irão implicar no cuidado entregue ao paciente. A avaliação da qualidade do produto do cuidado de enfermagem, especialmente quando relacionada ao ambiente da prática profissional, é de extrema importância para garantir a entrega de uma assistência eficaz e segura. A qualidade do cuidado de enfermagem não apenas afeta diretamente a saúde e o bem-estar dos pacientes, mas também influencia a satisfação dos profissionais de enfermagem e a eficácia geral do sistema de saúde. Dessa forma, compreender como elementos do ambiente laboral impactam na entrega de cuidados de enfermagem é crucial para implementar estratégias eficazes que promovam uma prática profissional de excelência, pautada na execução de uma assistência segura, eficaz e centrada no paciente. Ao delinear e analisar os preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem associados ao ambiente de trabalho, esta pesquisa buscará contribuir para a melhoria contínua da qualidade do cuidado de enfermagem, atrelada a ambientes de atuação profissional salubres e profícuos. O estudo se propõe a responder a seguinte questão de pesquisa: Quais são os preditores da qualidade

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº 80, sala 17, Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar.  
Bairro: Centro Histórico CEP: 90.035-190  
UF: RS Município: PORTO ALEGRE  
Telefone: (51)3214-8571 Fax: (51)3214-8571 E-mail: cep@santacasa.tche.br

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE PORTO  
ALEGRE - ISCMPA



Continuação do Parecer: 7.018.796

do produto do cuidado de enfermagem relacionados ao ambiente da prática profissional?

**Objetivo da Pesquisa:**

**Objetivo Primário:**

Analisar preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem relacionados ao ambiente da prática profissional.

**Objetivo Secundário:**

¿Caracterizar os enfermeiros quanto aos aspectos sociodemográficos, de formação e laborais;¿Avaliar o produto do cuidado de enfermagem;

¿Avaliar o ambiente da prática profissional de enfermagem;

¿Verificar a correlação das variáveis preditoras da qualidade do produto do cuidado;¿Conhecer a percepção de enfermeiros acerca dos fatores do seu ambiente de prática profissional que influenciam na qualidade do produto do cuidado.

**Avaliação dos Riscos e Benefícios:**

**Riscos:**

Em relação aos riscos, este estudo pode oferecer riscos mínimos, em virtude da possibilidade de desconforto relacionada à reflexão sobre prática profissional no cuidado de pacientes. Além disso, medidas de segurança serão implementadas para garantir a proteção dos dados e evitar qualquer tipo de violação de privacidade.

**Benefícios:**

Quanto aos benefícios, estes incluem a geração de conhecimento científico relevante para a área da saúde, com possibilidade de contribuir para melhorias no contexto do ambiente da prática profissional, especialmente no que diz respeito a obtenção de insights para a implementação de estratégias que favoreçam a prática profissional, resultando em melhor qualidade de cuidado, satisfação profissional e contribuindo para o avanço do conhecimento nessa temática.

**Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:**

Proposta de estudo de método misto, de delineamento explanatório sequencial e atribuição de peso quantitativa. Os participantes do estudo serão enfermeiros assistenciais de unidades de internação e unidade de terapia intensiva adulto dos hospitais pertencentes ao complexo hospitalar de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Na primeira fase, quantitativa e prioritária, será realizada uma pesquisa transversal. A uma amostra mínima de 118

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº 80, sala 17, Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar.  
Bairro: Centro Histórico CEP: 90.035-190  
UF: RS Município: PORTO ALEGRE  
Telefone: (51)3214-8571 Fax: (51)3214-8571 E-mail: cep@santacasa.tche.br

**IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE PORTO  
ALEGRE - ISCMPA**



Continuação do Parecer: 7.010.795

enfermeiros será fornecido três instrumentos: 1) Questionário de caracterização dos participantes e preditores de qualidade do cuidado; 2) Escala Ambiente de Trabalho da Prática de Enfermagem (PESNWI) e 3) Avaliação do Produto do Cuidar em Enfermagem (APROCENF). Aos dados tabulados, será aplicada análise estatística descritiva, inferencial e um modelo de regressão de Poisson. A variável dependente será a qualidade do produto do cuidado de enfermagem estratificada, relacionada às características do ambiente da prática das unidades. Por meio de procedimento de conexão, o estudo avançará à etapa qualitativa, secundária. Esta ocorrerá por meio de entrevistas guiadas diretamente pelos dados estatísticos de maior interesse para compreensão mais aprofundada, identificados na primeira etapa. Por fim, será realizada análise integrativa dos dados quantitativos e qualitativos, por meio de interpretações, metainferências e joint displays.

**Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:**

Vide campo Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações.

**Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:**

Em atenção a (s) pendência(s) emitida (s) no parecer consubstanciado número 6.960.417 emitido em 22/07/2024, por este CEP da ISCMPA, listo abaixo os itens elencados e as respectivas modificações para análise ética:

**Pendência 1:**

**1) TCLE etapa quanti e quali:**

a) A frase sobre os custos e reembolso ainda não está completamente elucidada. Por favor, modificar a frase para "Você, seu plano de saúde (se você tiver um) e o SUS (Sistema Único de Saúde) não terão nenhum tipo custo. Os pesquisadores deste estudo serão responsáveis pelo reembolso das despesas ocorridas como resultado de sua participação neste estudo, tais como transporte e alimentação, bem como as despesas de seus acompanhantes, quando necessário".

**Resposta pendência 1:**

a) Modificado nos TCLE a frase. Alterações realizadas no projeto (projeto detalhado/brochura e página 56 e 60 da versão 3 do arquivo projeto detalhado) e nos documentos individuais que trazem ambos os TCLE. Alteração grifada em amarelo.

**Pendência 2:**

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº 80, sala 17, Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar.  
Bairro: Centro Histórico CEP: 90.035-190  
UF: RS Município: PORTO ALEGRE  
Telefone: (51)3214-8571 Fax: (51)3214-8571 E-mail: cep@santacasa.tche.br

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE PORTO  
ALEGRE - ISCMPA



Continuação do Parecer: 7.010.726

2) Riscos:

- a) Não Informa como o "desconforto associado ao pensamento diante de lembranças de situações vivenciadas" serão administrados pelos pesquisadores.
- b) Não esclarece sobre a privacidade dos dados pessoais (como os dados pessoais sensíveis serão de fato anonimizados).

Resposta pendência 2:

- a) Inserido nos TCLE como será administrado pelos pesquisadores os riscos mencionados. Alterações realizadas no projeto (projeto detalhado/brochura e página 56 e 60 da versão 3 do arquivo projeto detalhado) e nos documentos Individuais que trazem ambos os TCLE. Alteração grifada em amarelo.
- b) Esclarecido sobre como os dados pessoais sensíveis serão de fato anonimizados. Alterações realizadas no projeto (projeto detalhado/brochura e página 56 e 60 da versão 3 do arquivo projeto detalhado) e nos documentos Individuais que trazem ambos os TCLE. Alteração grifada em amarelo.

Pendência 3:

Se a pesquisa ocorrerá somente na Santa Casa, quem será o contato aqui na Instituição?

Resposta pendência 3:

A pesquisadora responsável Nicole Hertzog Rodrigues atua como supervisora de enfermagem da Santa Casa de Porto Alegre, esta será o contato na Instituição. Para tanto, consta no TCLE o número de celular da mesma e agora, o ramal Institucional para contato. Alterações realizadas no projeto (projeto detalhado/brochura e página 56 e 60 da versão 3 do arquivo projeto detalhado) e nos documentos Individuais que trazem ambos os TCLE. Alteração grifada em amarelo.

Ajustado ainda o cronograma do estudo visto pendências emitidas (período do início da coleta de dados quantitativa, sua análise e coleta de dados qualitativa). Alteração realizada conforme orientação descrita pelo CEP SCPA: e cronograma de atividades: sempre considerar o início das atividades do estudo 30 dias após a reunião de colegiado deste CEP. Vide página 38 da versão 3 do projeto detalhado, alterações grifadas em amarelo.

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº 80, sala 17, Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar.  
Bairro: Centro Histórico CEP: 90.035-190  
UF: RS Município: PORTO ALEGRE  
Telefone: (51)3214-8571 Fax: (51)3214-8571 E-mail: cep@santacasa.tche.br

**IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE PORTO  
ALEGRE - ISCMPA**



Continuação do Parecer: 7.010.790

Devido aos ajustes realizados, foram anexados na Plataforma Brasil os seguintes documentos atualizados:

- Projeto detalhado/Brochura Investigador (cronograma: página 38, TCLE etapa quantitativa: página 56 e TCLE etapa qualitativa: página 60)
- TCLE (TCLE etapa quantitativa e TCLE etapa qualitativa)
- Cronograma

**ANÁLISE: TODAS AS PENDÊNCIAS FORAM ATENDIDAS.**

**Considerações Finais a critério do CEP:**

Diante do exposto, este Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA), de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS n° 466 de 2012 e na Resolução CNS n° 706 de 2023, manifesta-se pela aprovação do protocolo de pesquisa.

**Observações:**

- 1 - Para o início do estudo, o pesquisador responsável deverá apresentar o Parecer Consubstanciado de aprovação pelo CEP da ISCMPA a chefe do serviço onde será realizada a pesquisa.
- 2- Solicitações de acesso e crachá devem ser encaminhados ao endereço de e-mail: pesquisa@santacasa.org.br e anexar o arquivo do Parecer Consubstanciado e o arquivo Informações Básicas do Projeto (gerados pela Plataforma Brasil). Se houver necessidade de dados estruturados a partir de prontuários, o pedido também deverá ser enviado para pesquisa@santacasa.org.br detalhando todos os itens necessários. O prazo de emissão do relatório é 30 dias após a abertura de ordem de serviço para a TI.
- 3 - É dever do pesquisador responsável encaminhar a este CEP os relatórios de andamento do projeto desenvolvido na ISCMPA (pesquisas com duração superior a 6 meses) e relatório final (ao término do estudo), além dos resultados obtidos (cópia da publicação).

**Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:**

| Tipo Documento                 | Arquivo                                       | Postagem               | Autor                    | Situação |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| Informações Básicas do Projeto | PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2355731.pdf | 20/08/2024<br>07:41:58 |                          | Aceito   |
| Outros                         | Carta_resposta_CEP_word.docx                  | 20/08/2024<br>07:41:08 | NICOLE HERTZOG RODRIGUES | Aceito   |

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº 80, sala 17, Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar.  
 Bairro: Centro Histórico CEP: 90.035-190  
 UF: RS Município: PORTO ALEGRE  
 Telefone: (51)3214-8571 Fax: (51)3214-8571 E-mail: cep@santacasa.tche.br

**IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE PORTO  
ALEGRE - ISCMPA**



Continuação do Parecer: 7.018.796

|                                                           |                                              |                        |                             |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| Outros                                                    | Carta_resposta_parecer_CEP_PDF.pdf           | 20/08/2024<br>07:36:35 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência | Versao3_TCLE_Etapa_Quali.docx                | 20/08/2024<br>07:36:09 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência | Versao3_TCLE_Etapa_Quantl.docx               | 20/08/2024<br>07:36:02 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Cronograma                                                | Versao3_Cronograma.docx                      | 20/08/2024<br>07:35:41 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Projeto Detalhado / Brochura Investigador                 | versao3_Projeto_Doutorado.docx               | 20/08/2024<br>07:35:21 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                                    | Carta_resposta_parecer_CEP_assinado.pdf      | 20/07/2024<br>16:05:09 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                                    | Carta_resposta_parecer_CEP.docx              | 20/07/2024<br>16:04:47 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Cronograma                                                | Versao2_Cronograma.docx                      | 20/07/2024<br>16:04:13 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência | Versao2_TCLE_Etapa_Quantl.docx               | 20/07/2024<br>16:03:58 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência | Versao2_TCLE_Etapa_Quali.docx                | 20/07/2024<br>16:03:27 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Projeto Detalhado / Brochura Investigador                 | versao2_Projeto_Doutorado.docx               | 20/07/2024<br>16:03:13 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                                    | aprovacao_viabilidade_formulario.jpeg        | 19/06/2024<br>14:36:50 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                                    | Roteiro_entrevista_semi_estruturada.docx     | 19/06/2024<br>13:41:39 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência | TCLE_Etapa_Quantl.docx                       | 19/06/2024<br>13:40:37 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência | TCLE_Etapa_Quali.docx                        | 19/06/2024<br>13:40:31 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                                    | Instrumento_questionario_caracterizacao.docx | 19/06/2024<br>13:36:56 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                                    | Instrumento_APROCENF.docx                    | 19/06/2024             | NICOLE HERTZOG              | Acelto |

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº 80, sala 17, Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar.  
 Bairro: Centro Histórico CEP: 90.035-190  
 UF: RS Município: PORTO ALEGRE  
 Telefone: (51)3214-8571 Fax: (51)3214-8571 E-mail: cep@santacasa.br

**IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE PORTO  
ALEGRE - ISCMPA**



Continuação do Parecer: 7.010.790

|                                                 |                                                                          |                        |                             |        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| Outros                                          | Instrumento_APROCENF.docx                                                | 13:36:22               | RODRIGUES                   | Acelto |
| Outros                                          | Instrumento_PESNWI.docx                                                  | 19/06/2024<br>13:34:30 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Orçamento                                       | Orcamento.docx                                                           | 19/06/2024<br>13:30:20 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Cronograma                                      | Cronograma.docx                                                          | 19/06/2024<br>13:30:10 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                          | Declaracao_confidencialidade_word.docx                                   | 19/06/2024<br>13:26:41 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                          | Declaracao_de_confidencialidade_assinado.pdf                             | 19/06/2024<br>13:26:26 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                          | Declaracao_Isencao_onus_a_Instituicao_word.docx                          | 19/06/2024<br>13:25:17 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                          | Declaracao_Isencao_onus_a_Instituicao_assinado.pdf                       | 19/06/2024<br>13:24:58 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                          | DeclaracaoBanco_Dados_word.docx                                          | 19/06/2024<br>13:13:31 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                          | Declaracao_De_Utilizacao_eou_Constituicao_De_Banco_De_Dados_assinado.pdf | 19/06/2024<br>13:11:36 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                          | Termo_processo_consentimento_word.docx                                   | 19/06/2024<br>13:09:11 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                          | Termo_processo_consentimento_assinado.pdf                                | 19/06/2024<br>13:08:17 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                          | Termo_anuencia_word.docx                                                 | 19/06/2024<br>13:04:24 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Outros                                          | Termo_anuencia_assinado.pdf                                              | 19/06/2024<br>13:03:56 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Projeto Detalhado /<br>Brochura<br>Investigador | Projeto_Doutorado.docx                                                   | 19/06/2024<br>12:55:48 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |
| Folha de Rosto                                  | Folha_de_rosto_Nicole.pdf                                                | 19/06/2024<br>12:45:11 | NICOLE HERTZOG<br>RODRIGUES | Acelto |

**Situação do Parecer:**

Aprovado

**Necessita Apreciação da CONEP:**

Não

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, nº 80, sala 17, Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar.

Bairro: Centro Histórico

CEP: 90.035-190

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3214-8571

Fax: (51)3214-8571

E-mail: cep@santacasa.tche.br

IRMANDADE DA SANTA CASA  
DE MISERICORDIA DE PORTO  
ALEGRE - ISCMPA



Continuação do Parecer: 7.010.796

PORTO ALEGRE, 20 de Agosto de 2024

---

Assinado por:  
RENAN CAVALHEIRO LANGIE  
(Coordenador(a))

**Endereço:** Avenida Osvaldo Aranha, nº 80, sala 17, Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar.  
**Bairro:** Centro Histórico **CEP:** 90.035-100  
**UF:** RS **Município:** PORTO ALEGRE  
**Telefone:** (51)3214-8571 **Fax:** (51)3214-8571 **E-mail:** cep@santacasa.tche.br



## APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES E DOS PREDITORES DE QUALIDADE DO CUIDADO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem

Título do Estudo: Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem

| CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES                         |                                                                                                                                                                                                    | CODIFICAÇÃO                                                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qual é o seu sexo?                                       | <input type="checkbox"/> masculino<br><input type="checkbox"/> feminino<br><input type="checkbox"/> Não informado                                                                                  | (0) masculino<br>(1) feminino<br>(2) Não informado                                        |
| Qual é a sua idade?                                      | _____ anos                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| Qual seu estado civil?                                   | <input type="checkbox"/> solteiro(a)<br><input type="checkbox"/> casado(a)<br><input type="checkbox"/> divorciado(a)<br><input type="checkbox"/> viúvo(a)<br><input type="checkbox"/> outro        | (1) solteiro(a)<br>(2) casado(a)<br>(3) divorciado(a)<br>(4) viúvo(a)<br>(5) outro        |
| Turno de atuação                                         | <input type="checkbox"/> manhã<br><input type="checkbox"/> tarde<br><input type="checkbox"/> noite<br><input type="checkbox"/> folguista                                                           | (1) manhã<br>(2) tarde<br>(3) noite<br>(4) folguista                                      |
| Quantos anos atua como enfermeiro?                       | _____ anos                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| Há quantos anos trabalha neste Hospital?                 | _____ anos                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| Há quantos anos atua em unidade de internação?           | _____ anos                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| Qual a natureza da instituição que realizou a graduação? | <input type="checkbox"/> pública<br><input type="checkbox"/> privada                                                                                                                               | (0) pública<br>(1) privada                                                                |
| Qual é o seu maior grau de formação (titulação)?         | <input type="checkbox"/> graduação<br><input type="checkbox"/> especialização<br><input type="checkbox"/> mestrado<br><input type="checkbox"/> doutorado<br><input type="checkbox"/> pós-doutorado | (1) graduação<br>(2) especialização<br>(3) mestrado<br>(4) doutorado<br>(5) pós-doutorado |
| Qual é o seu hospital e sua unidade de atuação?          | Hospital _____<br>Unidade _____                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| PREDITORES DE QUALIDADE DO CUIDADO                       |                                                                                                                                                                                                    | CODIFICAÇÃO                                                                               |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qual o quantitativo de leitos da unidade?                                                                                                                            | <input type="radio"/> até 10<br><input type="radio"/> de 11 a 15<br><input type="radio"/> de 16 a 20<br><input type="radio"/> 21 a 30<br><input type="radio"/> 31 a 40<br><input type="radio"/> acima de 40 | (1) até 10<br>(2) de 11 a 15<br>(3) de 16 a 20<br>(4) 21 a 30<br>(5) 31 a 40<br>(6) acima de 40 |
| Ocorreu absenteísmo de algum trabalhador de enfermagem neste turno/plantão?                                                                                          | <input type="radio"/> sim<br><input type="radio"/> não                                                                                                                                                      | (0) sim<br>(1) não                                                                              |
| Foi necessário algum remanejo de pessoal ou hora-extra neste turno/plantão?                                                                                          | <input type="radio"/> sim<br><input type="radio"/> não                                                                                                                                                      | (0) sim<br>(1) não                                                                              |
| Em geral, você considera que a equipe de enfermagem da sua unidade é adequadamente dimensionada?                                                                     | <input type="radio"/> sim<br><input type="radio"/> não                                                                                                                                                      | (0) sim<br>(1) não                                                                              |
| Qual o quantitativo de pacientes que estão sob sua responsabilidade nesta unidade?                                                                                   | <input type="radio"/> até 10<br><input type="radio"/> de 10 a 20<br><input type="radio"/> de 20 a 30<br><input type="radio"/> 30 ou mais                                                                    | (1) até 10<br>(2) de 10 a 20<br>(3) de 20 a 30<br>(4) 30 ou mais                                |
| Qual o quantitativo de pacientes que estão sob responsabilidade do técnico de enfermagem desta unidade?                                                              | <input type="radio"/> até 4<br><input type="radio"/> 5<br><input type="radio"/> 6<br><input type="radio"/> 7<br><input type="radio"/> 8 ou mais                                                             | (1) até 4<br>(2) de 10 a 20<br>(3) de 20 a 30<br>(4) 30 ou mais<br>(5) 8 ou mais                |
| Você possui na equipe técnico de enfermagem integrado ao Hospital a menos de 3 meses?                                                                                | <input type="radio"/> sim<br><input type="radio"/> não                                                                                                                                                      | (0) sim<br>(1) não                                                                              |
| Durante seu plantão, ocorreu algum evento adverso moderado ou grave? Exemplos: erro de medicação, quedas, retirada acidental de sonda, entre outros.                 | <input type="radio"/> sim<br><input type="radio"/> não                                                                                                                                                      | (0) sim<br>(1) não                                                                              |
| Houve a necessidade de acionamento do time de resposta rápida?                                                                                                       | <input type="radio"/> sim<br><input type="radio"/> não                                                                                                                                                      | (0) sim<br>(1) não                                                                              |
| Houve algum conflito interpessoal entre a equipe de enfermagem ou outro membro da equipe de saúde?                                                                   | <input type="radio"/> sim<br><input type="radio"/> não                                                                                                                                                      | (0) sim<br>(1) não                                                                              |
| Ao longo do plantão, todos os recursos materiais necessários para a prestação do cuidado estavam disponíveis?                                                        | <input type="radio"/> sim<br><input type="radio"/> não                                                                                                                                                      | (0) sim<br>(1) não                                                                              |
| Houve atraso no encaminhamento de pacientes para exames?                                                                                                             | <input type="radio"/> sim<br><input type="radio"/> não                                                                                                                                                      | (0) sim<br>(1) não                                                                              |
| A transição de cuidados do seu colega do turno anterior foi realizada de forma a lhe permitir possuir as informações necessárias para a continuidade da assistência? | <input type="radio"/> sim<br><input type="radio"/> não                                                                                                                                                      | (0) sim<br>(1) não                                                                              |
| Ao longo do plantão, você e sua equipe conseguiram registrar em prontuário toda a assistência prestada ao paciente?                                                  | <input type="radio"/> sim<br><input type="radio"/> não                                                                                                                                                      | (0) sim<br>(1) não                                                                              |

|                                                                                                                                              |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Todos os pacientes foram prescritos respeitando o prazo de validade da prescrição sem que ocorresse atraso na administração de medicamentos? | ( ) sim<br>( ) não | (0) sim<br>(1) não |
| Em uma escala de 0 a 10 qual é o seu nível de satisfação com o seu emprego                                                                   |                    |                    |
| Em uma escala de 0 a 10 qual é o seu nível de satisfação com a sua profissão                                                                 |                    |                    |
| Em uma escala de 0 a 10 qual é a sua intenção de deixar este emprego                                                                         |                    |                    |
| Em uma escala de 0 a 10 qual é a sua intenção de deixar a sua profissão                                                                      |                    |                    |
| Em uma escala de 0 a 10 qual é a sua avaliação sobre o nível de qualidade do cuidado de enfermagem prestado nesta unidade                    |                    |                    |

## **APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ETAPA QUANTITATIVA**

Título do projeto de pesquisa: Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem

Data da versão: 20/05/2024

Página 1 de 2

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada “Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem”, cujo objetivo é avaliar os preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem relacionados ao ambiente da prática profissional. O ambiente de trabalho da enfermagem é definido pelas condições do local de trabalho que tornam mais fácil ou desafiadora a prestação de cuidados, a organização do trabalho e a qualidade da assistência. Determinados elementos do ambiente laboral, como por exemplo, carga de trabalho, proporção paciente/enfermeiro, nível de capacitação do pessoal de enfermagem, índice de rotatividade de enfermeiros, além das chamadas *soft skills*, como comunicação, trabalho em equipe e liderança, influenciam no produto do cuidado de enfermagem. Compreender como elementos do ambiente laboral podem prever a entrega (des)qualificada de cuidados de enfermagem é crucial para implementar estratégias eficazes que promovam uma prática profissional (cuidado) de excelência, sustentada por um ambiente de trabalho salutar e profícuo.

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária e consistirá em responder a 3 instrumentos de coleta de dados relacionados ao seu ambiente de prática profissional, estima-se que o tempo de preenchimento seja de 20 minutos. As informações do presente estudo serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar sua identidade.

A participação no estudo não trará benefício pessoal para o participante, porém contribuirá para o aumento do conhecimento sobre o assunto estudado e os resultados poderão auxiliar na realização de estudos futuros. A sua participação não implica no pagamento e nem no recebimento de qualquer quantia financeira. O participante tem o direito de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer momento da pesquisa, sem nenhum prejuízo ou penalização. Os resultados serão divulgados em conjunto e seu nome não será divulgado, os dados serão utilizados apenas pela equipe do estudo. Possui-se garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.

Os possíveis benefícios são para a melhoria do processo de trabalho assistencial dos enfermeiros, pois os resultados da pesquisa podem contribuir para a identificação dos fatores que influenciam na qualidade assistencial.

---

Rubrica do participante

---

Rubrica do pesquisador

A pesquisa oferecerá o mínimo risco aos participantes, o qual está relacionado ao tempo dedicado para participar das etapas do estudo, além da possibilidade de ocorrência de certo desconforto em responder algum tema abordado nos instrumentos.

Aos participantes desta pesquisa fica garantido o direito de receber resposta a qualquer dúvida sobre os assuntos relacionados ao estudo. O contato do pesquisador responsável Prof. Dr. João Lucas Campos de Oliveira e da pesquisadora Nicole Hertzog Rodrigues é pelo telefone (51) 99680-4258 ou pelo endereço da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Rua São Manoel, 963. Para qualquer pergunta sobre os seus direitos como participante deste estudo, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre (CEP SCPA) no telefone: (51) 3214-8571, endereço Av. Osvaldo Aranha, nº80, sala 17 - Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar. Bairro Centro Histórico, Porto Alegre – RS. Horário de Atendimento: de 2ª a 6ª, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h – para questões sobre a pesquisa e sobre os direitos dos pacientes envolvidos ou sobre problemas decorrentes da pesquisa, contatar a pesquisadora principal deste estudo.

Por meio da assinatura deste documento, você autoriza a sua participação na pesquisa. Serão assinadas duas vias deste termo de consentimento, ficando uma com o participante e outra com o pesquisador. Ao final do estudo, você terá contribuído para a avaliação dos preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem.

Ao assinalar a opção abaixo, você confirma que leu as afirmações contidas neste termo de consentimento e que está satisfeito com as informações fornecidas e que decidiu participar voluntariamente deste estudo.

( ) Declaro que aceito participar da pesquisa “Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem.”

Porto Alegre, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

Nome do participante: \_\_\_\_\_

Assinatura do participante: \_\_\_\_\_

Nome do pesquisador: \_\_\_\_\_

Assinatura do pesquisador: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Rubrica do participante

\_\_\_\_\_  
Rubrica do pesquisador

## **APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - ETAPA QUALITATIVA**

Título do projeto de pesquisa: Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem

Data da versão: 20/05/2024

Página 1 de 2

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada “Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem”, cujo objetivo é avaliar os preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem relacionados ao ambiente da prática profissional. O ambiente de trabalho da enfermagem é definido pelas condições do local de trabalho que tornam mais fácil ou desafiadora a prestação de cuidados, a organização do trabalho e a qualidade da assistência. Determinados elementos do ambiente laboral, como por exemplo, carga de trabalho, proporção paciente/enfermeiro, nível de capacitação do pessoal de enfermagem, índice de rotatividade de enfermeiros, além das chamadas *soft skills*, como comunicação, trabalho em equipe e liderança, influenciam no produto do cuidado de enfermagem. Compreender como elementos do ambiente laboral podem prever a entrega (des)qualificada de cuidados de enfermagem é crucial para implementar estratégias eficazes que promovam uma prática profissional (cuidado) de excelência, sustentada por um ambiente de trabalho salutar e produtivo.

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária e consistirá em responder a um instrumento de caracterização de dados sociodemográficos, formação acadêmica e laboral e responder a uma entrevista sobre o assunto que durará em média 20 minutos. A entrevista será realizada em local privado e silencioso e será gravada. As gravações das entrevistas serão destruídas e as transcrições serão guardadas por um período de cinco anos, em local sigiloso sob responsabilidade da pesquisadora e, após, serão destruídas. As informações do presente estudo serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar sua identidade.

A participação no estudo não trará benefício pessoal para o participante, porém contribuirá para o aumento do conhecimento sobre o assunto estudado e os resultados poderão auxiliar na realização de estudos futuros. A sua participação não implica no pagamento e nem no recebimento de qualquer quantia financeira. O participante tem o direito de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer momento da pesquisa, sem nenhum prejuízo ou penalização. Os resultados serão divulgados em conjunto e seu nome não será divulgado, os dados serão utilizados apenas pela equipe do estudo. Possui-se garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.

---

Rubrica do participante

---

Rubrica do pesquisador

Os possíveis benefícios são para a melhoria do processo de trabalho assistencial dos enfermeiros, pois os resultados da pesquisa podem contribuir para a identificação dos fatores que influenciam na qualidade assistencial. A pesquisa oferecerá o mínimo risco aos participantes, o qual está relacionado ao tempo dedicado para participar das etapas do estudo, além da possibilidade de ocorrência de certo desconforto em responder algum tema abordado durante a realização da entrevista.

Aos participantes desta pesquisa fica garantido o direito de receber resposta a qualquer dúvida sobre os assuntos relacionados ao estudo. O contato do pesquisador responsável Prof. Dr. João Lucas Campos de Oliveira e da pesquisadora Nicole Hertzog Rodrigues é pelo telefone (51) 99680-4258 ou pelo endereço da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Rua São Manoel, 963. Para qualquer pergunta sobre os seus direitos como participante deste estudo, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre (CEP SCPA) no telefone: (51) 3214-8571, endereço Av. Osvaldo Aranha, nº80, sala 17 - Centro Administrativo da Santa Casa, 2º andar. Bairro Centro Histórico, Porto Alegre – RS. Horário de Atendimento: de 2ª a 6ª, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h – para questões sobre a pesquisa e sobre os direitos dos pacientes envolvidos ou sobre problemas decorrentes da pesquisa, contatar a pesquisadora principal deste estudo.

Por meio da assinatura deste documento, você autoriza a sua participação na pesquisa. Serão assinadas duas vias deste termo de consentimento, ficando uma com o participante e outra com o pesquisador. Ao final do estudo, você terá contribuído para a avaliação dos preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem.

Ao assinalar a opção abaixo, você confirma que leu as afirmações contidas neste termo de consentimento e que está satisfeito com as informações fornecidas e que decidiu participar voluntariamente deste estudo.

( ) Declaro que aceito participar da pesquisa “Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem.”

Porto Alegre, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

Nome do participante: \_\_\_\_\_

Assinatura do participante: \_\_\_\_\_

Nome do pesquisador: \_\_\_\_\_

Assinatura do pesquisador: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Rubrica do participante

\_\_\_\_\_  
Rubrica do pesquisador

## APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem

Título do Estudo: Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem

Hospital:

Setor:

| CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES                         |                                                                                           | CODIFICAÇÃO                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qual é o seu sexo?                                       | ( ) masculino<br>( ) feminino                                                             | (0) masculino<br>(1) feminino                                                             |
| Qual é a sua idade?                                      | _____ anos                                                                                |                                                                                           |
| Qual seu estado civil?                                   | ( ) solteiro(a)<br>( ) casado(a)<br>( ) divorciado(a)<br>( ) viúvo(a)<br>( ) outro        | (1) solteiro(a)<br>(2) casado(a)<br>(3) divorciado(a)<br>(4) viúvo(a)<br>(5) outro        |
| Turno de atuação                                         | ( ) manhã<br>( ) tarde<br>( ) noite<br>( ) folguista                                      | (1) manhã<br>(2) tarde<br>(3) noite<br>(4) folguista                                      |
| Quantos anos atua como enfermeiro?                       | _____ anos                                                                                |                                                                                           |
| Há quantos anos trabalha neste Hospital?                 | — anos                                                                                    |                                                                                           |
| Há quantos anos atua em unidade de internação?           | _____ anos                                                                                |                                                                                           |
| Qual a natureza da instituição que realizou a graduação? | ( ) pública<br>( ) privada                                                                | (0) pública<br>(1) privada                                                                |
| Qual é o seu maior grau de formação (titulação)?         | ( ) graduação<br>( ) especialização<br>( ) mestrado<br>( ) doutorado<br>( ) pós-doutorado | (1) graduação<br>(2) especialização<br>(3) mestrado<br>(4) doutorado<br>(5) pós-doutorado |

**Questão norteadora:** Qual a sua percepção acerca dos fatores do ambiente de trabalho que influenciam a qualidade assistencial?

### Perguntas de apoio:

- De que forma o quantitativo de profissionais e a carga de trabalho influenciam o cuidado de enfermagem que você oferece aos pacientes?



- Como a disponibilidade de recursos materiais impacta na qualidade do cuidado de enfermagem prestado aos pacientes?
- Como você percebe o apoio da liderança de enfermagem (coordenadores/supervisores) na sua prática diária e na tomada de decisões assistenciais?
- Como os registros em prontuário, os planos de cuidados escritos e as transições entre turnos/setores se manifestam na sua prática cotidiana? Que impacto você percebe que eles têm na continuidade e qualidade da assistência de enfermagem?
- O que significa, para você, um “bom produto do cuidado” em enfermagem. Quais critérios você utiliza para avaliar este produto?

APÊNDICE E - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE ÔNUS À INSTITUIÇÃO

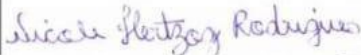


DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE ÔNUS À INSTITUIÇÃO

Porto Alegre, 18 de maio de 2024

**Título projeto de pesquisa:** Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem

Declaramos por meio deste documento que a pesquisa acima mencionada não acarretará nenhum tipo de ônus à Santa Casa de Porto Alegre (SCPA) e que o referido estudo com seres humanos será inteiramente custeado pelos pesquisadores.

| Pesquisadores envolvidos        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo                   | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nicole Hertzog Rodrigues        | <br><small>Documento assinado digitalmente</small>                                                                                                                                                                            |
| João Lucas Campos de Oliveira   |  <b>JOAO LUCAS CAMPOS DE OLIVEIRA</b><br><small>Data: 19/05/2024 10:45:07-0300<br/>Verifique em <a href="https://validar.it.gov.br">https://validar.it.gov.br</a></small>                                                     |
| Jéssica Azevedo Guardalupe      |  <b>JESSICA AZEVEDO GUARDALUPE</b><br><small>Data: 17/05/2024 16:23:43-0300<br/>Verifique em <a href="https://validar.it.gov.br">https://validar.it.gov.br</a></small>                                                        |
| Handyer Alakies Borges de Borba |  <small>Documento assinado digitalmente</small><br><b>HANDYER ALAKIES BORGES DE BORBA</b><br><small>Data: 17/05/2024 16:41:29-0300<br/>Verifique em <a href="https://validar.it.gov.br">https://validar.it.gov.br</a></small> |

APÊNDICE F - DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE DO PARTICIPANTE DA PESQUISA

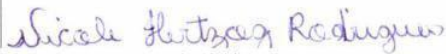


DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE DO PARTICIPANTE DA PESQUISA

Porto Alegre, 18 de maio de 2024

**Título projeto de pesquisa:** Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem

Asseguramos que os participantes de pesquisa incluídos no estudo acima mencionado terão a sua confidencialidade resguardada pela equipe envolvida na condução do projeto e que irão resguardar o sigilo e a confidencialidade, não havendo identificação dos indivíduos, conforme disposto na Resolução CNS nº 466 de 2012, Resolução CNS nº 510/2016, Norma Operacional nº 001 de 2013 e demais legislações complementares vigentes.

| Pesquisadores envolvidos        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo                   | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nicole Hertzog Rodrigues        | <br><small>Documento assinado digitalmente</small>                                                                                                                                                 |
| João Lucas Campos de Oliveira   |  <small>JOAO LUCAS CAMPOS DE OLIVEIRA</small><br><small>Data: 19/05/2024 10:45:07-0300</small><br><small>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></small>   |
| Jéssica Azevedo Guardalupe      |  <small>JESSICA AZEVEDO GUARDALUPE</small><br><small>Data: 17/05/2024 16:23:43-0300</small><br><small>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></small>      |
| Handyer Alakies Borges de Borba |  <small>HANDYER ALAKIES BORGES DE BORBA</small><br><small>Data: 17/05/2024 16:41:29-0300</small><br><small>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></small> |

## APÊNDICE G - DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E/OU CONSTITUIÇÃO DE BANCO DE DADOS



### DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E/OU CONSTITUIÇÃO DE BANCO DE DADOS

Porto Alegre, 18 de maio de 2024

**Título projeto de pesquisa:** Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem

**Local onde a pesquisa será realizada (hospital e serviço):** Unidades de internação e unidades de tratamento intensivo para adultos dos Hospitais pertencentes ao complexo hospitalar Santa Casa de Porto Alegre (SCPA).

Declaramos que ao constituir ou utilizar banco de dados a partir de informações pessoais e sensíveis, iremos agir com integridade e responsabilidade, garantiremos a confidencialidade, privacidade e intimidade; aplicaremos medidas de segurança (anonimização) e manteremos o conjunto dos dados em local seguro, com acesso restrito, controlado e rastreável. Também estamos comprometidos a não transferir dados a terceiros (exceto em situações específicas e devidamente previstas).

Sabemos que a responsabilidade de controlar o banco de dados e/ou de material biológico é do pesquisador responsável pelo protocolo de pesquisa (em conjunto com o patrocinador do estudo, se for o caso), estando devidamente descrito no Termo de Consentimento/Assentimento Livre e Esclarecido, ou, ainda, pessoa específica por ele delegada.

Afirmamos que foram descritos no projeto de pesquisa os procedimentos adotados para assegurar a confidencialidade dos dados, incluindo mecanismos de segurança e restrição de acessos.

Sabemos que os participantes de pesquisa são titulares dos seus dados e a eles está assegurado o direito de acesso às suas informações armazenadas, a qualquer tempo. Ainda, estamos cientes que caso haja danos decorrentes do uso indevido ou da quebra de segurança ou confidencialidade dos dados armazenados, o participante de pesquisa tem direito a indenização – de acordo o previsto na Resolução CNS nº 738 de 2024, Art. 15 e Art. 17.





Para constituição de bancos de dados para pesquisa, iremos seguir o disposto no Art. 18 da Resolução CNS nº 738 de 2024. A inclusão e a utilização de dados e informações do participante de pesquisa requerem o seu consentimento prévio ou do seu representante legal, poderá ocorrer com dispensa pelo Sistema CEP/Conep ou será solicitado novo consentimento dos participantes de pesquisa.

Nos casos de bancos de dados já constituídos, além dos itens acima supracitados e demais tópicos abaixo, o pesquisador responsável em conjunto com sua equipe, terá a autorização do Controlador dos dados para utilização e será anexada na Plataforma Brasil. Além disso, seguirá, obrigatoriamente, todos os pontos descritos no Art. 23 da Resolução CNS nº 738 de 2024.

Além disso, conforme estipulado na Resolução CNS nº 466 de 2012, Resolução CNS nº 510 de 2016, Norma Operacional nº 001 de 2013, declaramos o comprometimento em publicar cientificamente os resultados do estudo supracitado assegurando que os relatos sejam feitos de maneira ética, responsável e coerente, sejam eles favoráveis ou não. Os pesquisadores também manifestam conhecer e cumprir o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP, Lei nº 13.709 de 2018), principalmente quanto ao tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis que serão utilizados para a execução do estudo acima mencionado.

| Pesquisadores envolvidos        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo                   | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nicole Hertzog Rodrigues        | <br>Documento assinado digitalmente                                                                                                                                                             |
| João Lucas Campos de Oliveira   |  <b>JOAO LUCAS CAMPOS DE OLIVEIRA</b><br>Data: 19/05/2024 10:45:07-0300<br>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>                                      |
| Jéssica Azevedo Guardalupe      |  <b>JESSICA AZEVEDO GUARDALUPE</b><br>Data: 17/05/2024 16:23:43-0300<br>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>                                         |
| Handyer Alakies Borges de Borba |  Documento assinado digitalmente<br><b>HANDYER ALAKIES BORGES DE BORBA</b><br>Data: 17/05/2024 16:41:29-0300<br>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a> |

## APÊNDICE H - PROCESSO DE CONSENTIMENTO/ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO



### PROCESSO DE CONSENTIMENTO/ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Porto Alegre, 18 de maio de 2024

**Título projeto de pesquisa:** Ambiente da prática profissional e preditores da qualidade do produto do cuidado de enfermagem

O campo de estudo serão as unidades de internação e unidades de tratamento intensivo para adultos dos Hospitais pertencentes ao complexo hospitalar Santa Casa de Porto Alegre (SCPA). Os participantes do estudo serão enfermeiros assistenciais das unidades de internação e unidades de tratamento intensivo adulto que atuam no cenário de pesquisa.

Na definição da amostra, serão considerados os seguintes critérios de inclusão: atuar no cargo em tempo  $\geq$  seis meses e estar em pleno exercício profissional no período da coleta. Os critérios de exclusão serão: profissionais em afastamento laboral no período da coleta de dados e não atuar direta e rotineiramente na assistência ao paciente internado. Ambos os critérios serão adotados tanto na etapa quantitativa como qualitativa.

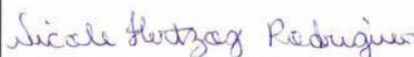
Por conseguinte, na etapa quantitativa, a amostra será formada por conveniência dos enfermeiros na participação. Já na etapa qualitativa, prevê-se como participantes da pesquisa 20 enfermeiros, sendo definido as duas unidades com piores e as duas unidades com melhores resultados da etapa quantitativa para a realização da coleta.

Na etapa quantitativa será realizada uma pesquisa transversal. Dessa forma, será realizada coleta de dados com enfermeiros *in loco* na instituição cenário do estudo, em local privado. A cada participante, em abordagem por conveniência e no próprio local de trabalho. Os enfermeiros que participarão da pesquisa serão convidados durante o período de trabalho e orientados quanto aos objetivos propostos neste estudo e o modo de preenchimento dos instrumentos utilizados na coleta de dados. Após os participantes aceitarem participar da pesquisa, será solicitado assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Os participantes receberão o TCLE, contendo informações quanto ao estudo, seus objetivos e riscos potenciais. A privacidade e o anonimato serão preservados, bem como o sigilo de suas informações. Os participantes permanecerão com uma cópia do TCLE e possuirão total liberdade de adesão, sendo assegurado o direito do pesquisado a suspender sua participação no estudo em qualquer momento, garantindo ainda sua segurança e proteção dos dados. Após assinado e explicado o TCLE os usuários receberão informações do andamento da pesquisa e como será realizada. Em relação aos riscos, este estudo pode oferecer riscos mínimos, em virtude da possibilidade de desconforto relacionada à reflexão sobre prática profissional no cuidado de pacientes. Os dados quantitativos, gerados a partir da primeira etapa, serão organizados e posteriormente tabulados pela pesquisadora, com auxílio do *Google Sheets*®.



Na abordagem qualitativa, as entrevistas serão gravadas por meio de áudio media player em meio digital. Prevendo os procedimentos que assegurassem a confiabilidade, privacidade, proteção e anonimato dos participantes, os mesmos serão identificados pela letra E, que representa a inicial da entrevista, prosseguido do número que representa a sequência dos depoimentos (E1, E2, E3,...). Após a transcrição da entrevista as gravações em áudio serão arquivadas por cinco anos com finalidade de preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa e após, destruídas. Os participantes serão entrevistados separadamente e em local privado.

| Pesquisadores envolvidos        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo                   | Assinatura                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nicole Hertzog Rodrigues        |                                                                                                                                                            |
| João Lucas Campos de Oliveira   | <div>gov.br</div> <div>Documento assinado digitalmente</div> <div>JOAO LUCAS CAMPOS DE OLIVEIRA</div> <div>Data: 19/05/2024 10:45:07-0300</div> <div>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></div>   |
| Jéssica Azevedo Guardalupe      | <div>gov.br</div> <div>Documento assinado digitalmente</div> <div>JESSICA AZEVEDO GUARDALUPE</div> <div>Data: 17/05/2024 16:23:43-0300</div> <div>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></div>      |
| Handyer Alakies Borges de Borba | <div>gov.br</div> <div>Documento assinado digitalmente</div> <div>HANDYER ALAKIES BORGES DE BORBA</div> <div>Data: 17/05/2024 16:41:29-0300</div> <div>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></div> |



**APÊNDICE I – ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELO  
RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO/LOCAL DA PESQUISA**

**TERMO DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELO  
RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO/LOCAL DA PESQUISA**

Título do Projeto de Pesquisa:

**AMBIENTE DA PRÁTICA PROFISSIONAL E PREDITORES DA QUALIDADE  
DO PRODUTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM**

Eu, JAQUELINE PETITTEMBERT FONSECA, Responsável Técnica de Enfermagem da Santa Casa de Porto Alegre, tenho ciência do projeto de pesquisa acima citado, desenvolvido sob a responsabilidade do Prof. Dr. João Lucas Campos de Oliveira, dos objetivos e metodologia a ser utilizada (utilização dos espaços destinados à assistência em saúde a fim de realizar a pesquisa), concordando com a realização dessa pesquisa na instituição.

Porto Alegre, 28 de maio de 2024.



Assinatura do responsável pela instituição/  
local de pesquisa